Athleta Manager

Descripción Integral del Sistema

Athleta Centro

Definición funcional del producto objetivo

Documento orientado a funcionalidades, reglas operativas, responsabilidades, escenarios de uso, privacidad y experiencia de usuario.

Desarrollado por

BROCO SOLUTIONS

Contenido

1. Propósito, alcance y principios del sistema
2. Visión general y conceptos transversales
3. Usuarios internos, roles y permisos
4. Acceso interno y gestión del Equipo
5. Personas: identidad, ficha y ciclo de vida
6. Sala
7. Clínica: Kinesiología y Osteopatía
8. Finanzas
9. Inicio y tableros operativos
10. Portal Athleta
11. Navegación, búsqueda y organización de la información
12. Criterios de UX/UI y comportamiento de la interfaz
13. Privacidad, seguridad funcional, integridad y trazabilidad
14. Catálogos y configuraciones funcionales
15. Escenarios integrales de uso
16. Límites funcionales y exclusiones
17. Glosario funcional

1. Propósito, alcance y principios del sistema

1.1 Propósito

Athleta Manager es el sistema web unificado de gestión de Athleta Centro. Su objetivo es concentrar en una única herramienta la operación cotidiana de Sala, Kinesiología y Osteopatía, junto con la información de personas, agenda, seguimiento, pagos, ingresos, gastos, usuarios internos y portal de alumnos y pacientes.

El sistema debe permitir que el equipo trabaje desde cualquier dispositivo con acceso web y que cada persona de Athleta tenga una identidad única, aun cuando participe simultáneamente de Sala y Clínica. La experiencia debe ser simple, rápida y comprensible para una organización pequeña, evitando circuitos administrativos que no aporten valor concreto.

1.2 Alcance funcional

La descripción cubre el producto objetivo completo desde el punto de vista funcional. Incluye reglas de negocio, responsabilidades, visibilidad de información, estados, flujos principales, excepciones relevantes y criterios de experiencia de usuario. No define arquitectura, base de datos, APIs, proveedor de infraestructura ni decisiones técnicas de implementación.

Athleta Manager se concibe como un solo sistema. Sala y Clínica son áreas diferenciadas por sus necesidades operativas y de privacidad, pero comparten la identidad de las personas, el acceso interno, la información general y determinadas relaciones funcionales.

1.3 Principio rector: simplicidad funcional

Toda funcionalidad debe resolver un problema operativo real con la menor cantidad razonable de pasos, estados y excepciones. La simplicidad no significa perder control: las acciones que afectan información clínica, responsabilidades profesionales, movimientos económicos o bajas relevantes conservan las protecciones necesarias.

- No se agregan roles, estados o permisos especiales sin una necesidad concreta.
- No se crean automatizaciones destructivas a partir de supuestos, como dar de baja por deuda o cerrar tratamientos por inactividad.
- Las advertencias se utilizan cuando existe una consecuencia relevante; las acciones normales no requieren confirmaciones innecesarias.
- La misma regla debe aplicarse de forma consistente en todo el sistema siempre que el contexto sea equivalente.
- El sistema prioriza la operación diaria por sobre métricas sofisticadas, configuraciones avanzadas o personalización excesiva.

1.4 Privacidad e integridad como límites de la simplicidad

La simplificación nunca debe exponer información clínica innecesariamente, permitir escaladas de privilegios, destruir historia relevante o producir resultados económicos incoherentes. Por eso la interfaz limita la información sensible al contexto en el que es necesaria, mantiene trazabilidad selectiva y protege las cuentas con mayor nivel de acceso.

1.5 Enfoque de producto

Athleta Manager debe sentirse como una herramienta propia de Athleta Centro. La marca Athleta es la protagonista visual. La presencia de Broco Solutions se mantiene de manera profesional y discreta, como firma de desarrollo, sin competir con las tareas operativas ni con la identidad de Athleta.

2. Visión general y conceptos transversales

2.1 Un sistema, una persona

Cada individuo se registra una sola vez como Persona. Esa misma Persona puede participar de Sala, tener actividad clínica o cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. No se duplican fichas por área.

La interfaz adapta el lenguaje al contexto: en Sala se utiliza “Alumno”; en Clínica, “Paciente”; en funciones transversales se utiliza “Persona”. Estos nombres representan distintas relaciones de la misma identidad, no entidades independientes.

2.2 Áreas funcionales

El sistema se organiza conceptualmente en áreas de trabajo claras: Inicio, Sala, Clínica, Finanzas y Equipo/Configuración. La navegación exacta puede adaptarse a escritorio o celular, pero el usuario no debe elegir un “modo Sala” o “modo Clínica” antes de trabajar.

Los usuarios con roles combinados ven naturalmente la unión de sus capacidades dentro de la misma aplicación.

2.3 Conceptos transversales principales

Concepto	Definición
Persona	Identidad única con datos generales, estado y relaciones con Sala/Clínica.
Alumno	Persona que participa actualmente de Sala.
Paciente	Persona dada de alta explícitamente en Clínica. Mantiene su condición de Paciente aunque luego no tenga actividad clínica vigente.
Usuario interno	Cuenta de trabajo perteneciente al Equipo de Athleta.
Turno	Evento agendado. En Sala se integra al esquema de reservas; en Clínica representa una consulta planificada.
Atención	Registro de que una consulta clínica efectivamente ocurrió.
Evolución	Documentación clínica asociada a una Atención.
Tratamiento clínico	Proceso de seguimiento clínico que puede abarcar múltiples Atenciones.
Indicación para Sala	Información clínica específicamente destinada a condicionar el entrenamiento.

2.4 Diferencia entre identidad, actividad y pertenencia a un área

Una Persona puede existir en el sistema sin estar actualmente Activa y puede pertenecer a Sala, Clínica o ambas áreas sin duplicar su identidad.

La condición de Alumno aparece cuando la Persona es incorporada explícitamente a Sala. La condición de Paciente aparece cuando la Persona es dada de alta explícitamente en Clínica. Si ya existe por otra área, el sistema reutiliza sus datos generales y solo solicita la información necesaria para la nueva incorporación.

Ser Alumno o Paciente no equivale al estado general Activo/Inactivo. Una Persona puede continuar siendo Paciente por su historia clínica y, al mismo tiempo, estar Inactiva porque no participa de Sala, no tiene Tratamientos En curso y no posee Turnos clínicos futuros Agendados.

2.5 Estado general de la Persona

Toda Persona tiene un único estado general visible: Activo o Inactivo. Este estado representa si existe una relación operativa vigente con Athleta.

La Persona se considera Activa cuando se cumple al menos una de estas condiciones: participa actualmente de Sala, tiene un Tratamiento clínico En curso o posee un Turno clínico futuro en estado Agendado.

Un Turno clínico Agendado mantiene Activa a la Persona solamente mientras su hora de inicio todavía no haya ocurrido. Al llegar esa hora deja de contar como actividad vigente, aunque el Turno continúe Agendado hasta que el equipo actualice su estado.

Cuando deja de cumplirse la última condición vigente, la Persona pasa automáticamente a Inactiva. Si aparece una nueva actividad vigente, vuelve automáticamente a Activa. Una Atención ya realizada, una Evaluación o un archivo histórico por sí solos no mantienen actividad vigente.

2.6 Formatos generales

La interfaz utiliza español y convenciones operativas de Argentina: fechas en formato dd/mm/aaaa, horarios en formato de 24 horas y moneda operativa en pesos argentinos. La referencia en dólares se utiliza únicamente en el contexto financiero definido para el Administrador general.

3. Usuarios internos, roles y permisos

3.1 Principio general de acceso interno

Los permisos internos se asignan mediante roles funcionales combinables. Una misma cuenta puede tener más de un rol cuando la persona cumple distintas responsabilidades dentro de Athleta. El sistema no utiliza perfiles personalizados por usuario ni excepciones individuales de permisos.

Todos los usuarios internos activos pueden buscar y consultar la existencia de las Personas registradas. La visibilidad de secciones y la capacidad de ejecutar acciones dependen de los roles.

3.2 Roles disponibles

Rol	Responsabilidad funcional
Profesor	Operación de Sala: alumnos, rutinas, evaluaciones físicas, agenda/asistencia, pagos de Sala e indicaciones clínicas visibles para entrenamiento.
Kinesiólogo	Operación clínica completa: historia clínica, atenciones, evoluciones, tratamientos, evaluaciones, estudios, indicaciones para Sala, biblioteca e IA.
Osteópata	Mismas capacidades clínicas que Kinesiología, conservando la identificación profesional correspondiente.
Administrativo	Operación transversal de personas, Sala, agenda clínica, órdenes, movimientos económicos y Equipo, sin acceso al contenido completo de Historia Clínica.
Administrador general	Acceso funcional completo a Athleta Manager, incluyendo Clínica, Finanzas, Equipo y configuración.
Soporte Broco	Acceso excepcional de soporte técnico/operativo, administrado exclusivamente por Broco Solutions.

3.3 Roles combinados

Los roles estándar de Athleta pueden combinarse. Los permisos resultantes son la suma natural de las capacidades de cada rol. No existe cambio de cuenta ni selector de modo.

Ejemplo: Una persona con roles Profesor y Kinesiólogo puede gestionar Sala y, al mismo tiempo, acceder a Historia Clínica como profesional clínico. Al buscar a una Persona ve ambas áreas desde la misma ficha.

3.4 Visibilidad y permisos resumidos

Función	Profesor	Kine/Osteo	Administrativo	Adm. general
Buscar Personas y ver datos generales	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestionar participación en Sala	Sí	No	Sí	Sí
Gestionar agenda/asistencia de Sala	Sí	No	Sí	Sí
Crear/modificar rutinas	Sí	No	Consulta	Sí
Registrar/corregir pago de Sala	Sí	No	Sí	Sí

Función	Profesor	Kine/Osteo	Administrativo	Adm. general
Ver Historia Clínica completa	No	Sí	No	Sí
Gestionar turnos clínicos	No	Sí	Sí	Sí
Registrar Atención sin contenido clínico	No	Sí	Sí	Sí
Crear Evolución/Evaluación clínica	No	Sí	No	Sí
Registrar ingreso clínico	No	Sí	Sí	Sí
Registrar gasto	Sí	Sí	Sí	Sí
Consultar historial general de gastos	No	No	Sí	Sí
Gestionar usuarios estándar del Equipo	No	No	Sí	Sí
Gestionar Administradores generales	No	No	No	Sí

La tabla resume los límites principales. Las reglas detalladas de cada módulo prevalecen cuando una acción requiere condiciones adicionales, como resolver responsabilidades profesionales antes de inactivar un usuario.

3.5 Profesor

El Profesor trabaja principalmente sobre Sala. Puede crear Personas, editar sus datos generales, incorporar o retirar alumnos de Sala, asignar o cambiar profesor principal, operar la agenda de Sala, registrar asistencias, gestionar rutinas, realizar evaluaciones físicas y registrar/corregir pagos de Sala.

Puede consultar las indicaciones clínicas que fueron preparadas para Sala, incluyendo la condición de cada indicación, zona afectada e instrucciones. No puede ingresar a antecedentes clínicos, evoluciones, evaluaciones clínicas, estudios ni tratamientos detallados salvo que además tenga un rol clínico.

El filtro “Mis alumnos” utiliza el profesor principal como criterio de organización, no como barrera de seguridad. Un Profesor puede consultar a otros alumnos de Sala cuando lo necesita.

3.6 Kinesiólogo y Osteópata

Kinesiólogo y Osteópata son dos roles distintos, aunque comparten las mismas capacidades clínicas generales dentro de Athleta Manager. La distinción conserva la identificación profesional de cada integrante sin crear módulos, agendas ni Historias Clínicas separadas. Ambos poseen acceso a la Historia Clínica completa y a las herramientas clínicas. Pueden trabajar con cualquier Paciente, independientemente de quién sea responsable de un Tratamiento. La responsabilidad profesional organiza el seguimiento, pero no restringe la consulta clínica entre profesionales.

Cuando una misma cuenta posee simultáneamente los roles Kinesiólogo y Osteópata, los registros clínicos identifican al profesional interviniente sin exigir seleccionar en cada Atención, Evolución o Evaluación con cuál de las dos disciplinas actuó. La cuenta puede identificarse como “Kinesiólogo / Osteópata”.

Un profesional clínico sin rol de Profesor puede saber si la Persona participa de Sala y consultar sus datos generales, pero no necesita acceso operativo a rutinas, pagos, evaluaciones físicas o agenda de Sala.

3.7 Administrativo

El Administrativo es un rol de confianza operativa. Puede gestionar Personas, altas y bajas de Sala, planes asignados, pagos, agenda de Sala, turnos clínicos, órdenes de obra social, ingresos clínicos, gastos y Equipo.

En Clínica puede operar la actividad administrativa sin ingresar al contenido completo de Historia Clínica. Puede agendar y reprogramar turnos, marcar estados, registrar que una Atención ocurrió, gestionar órdenes e ingresos y consultar referencias operativas necesarias. No puede leer o editar antecedentes, evoluciones, evaluaciones clínicas, estudios detallados, planes terapéuticos ni análisis de IA.

En Finanzas puede consultar listados operativos, filtros, historiales y totales. No dispone de la visión global de resultados y tendencias reservada al Administrador general.

3.8 Administrador general

El Administrador general posee acceso funcional completo al sistema. Puede consultar y operar Sala, Clínica, Finanzas, Personas, Equipo, catálogos y configuración.

El acceso completo no elimina reglas profesionales. Cuando una acción exige identificar a un profesional clínico responsable y el Administrador general no posee rol clínico, debe seleccionar un Kinesiólogo u Osteópata válido.

3.9 Soporte Broco

Soporte Broco es un rol excepcional destinado a resolver incidentes técnicos o de soporte. Puede requerir acceso amplio, incluso a información clínica, cuando el incidente lo justifica. No es un rol de operación cotidiana de Athleta.

Las acciones sensibles realizadas con una cuenta de Soporte Broco deben quedar identificadas como tales. Los usuarios de Athleta no pueden asignar este rol, modificar esas cuentas ni restablecer sus credenciales. Las cuentas de Soporte Broco pueden figurar identificadas dentro del mismo listado de Equipo para que el Administrador general sepa que existen, pero su administración corresponde exclusivamente a Broco Solutions.

4. Acceso interno y gestión del Equipo

4.1 Cuenta de usuario interno

Cada integrante del Equipo que utiliza Athleta Manager posee una cuenta interna independiente de cualquier ficha que pueda tener como Alumno o Paciente. La cuenta se utiliza exclusivamente para trabajar dentro del sistema.

El acceso interno se realiza mediante email y contraseña. El email es obligatorio y único dentro de las cuentas internas. Si el email de la ficha se modifica, el nuevo email pasa a ser el identificador utilizado para ingresar al sistema.

4.2 Ficha del integrante del Equipo

La ficha de un usuario interno registra información básica del integrante sin convertir Athleta Manager en un sistema de Recursos Humanos.

Son obligatorios Nombre, Apellido y Email. Son opcionales Teléfono, DNI, Domicilio, Fecha de nacimiento, Profesión y Fecha de ingreso a Athleta. Cuando se informa la Fecha de ingreso, la interfaz muestra la antigüedad calculada a partir de esa fecha.

Cada usuario interno puede consultar y modificar los datos de su propia ficha. El Email continúa siendo único entre cuentas internas y, si se modifica, pasa a ser el nuevo identificador de acceso.

Roles y estado Activo/Inactivo no son datos personales editables por autoservicio. Se administran únicamente mediante las reglas de gestión de Equipo correspondientes a Administrativo y Administrador general.

4.3 Alta y contraseña inicial

Al crear un usuario interno, el sistema genera automáticamente una contraseña temporal segura. La contraseña temporal se muestra para que sea comunicada manualmente al usuario y no queda disponible para consulta posterior.

En el primer acceso, el usuario debe reemplazar la contraseña temporal por una contraseña propia. No existe recuperación automática por email.

4.4 Cambio y restablecimiento de contraseña

Todo usuario puede cambiar su propia contraseña desde su cuenta.

El Administrativo puede restablecer la contraseña de usuarios estándar activos de Athleta: Profesor, Kinesiólogo, Osteópata y Administrativo. El sistema genera una nueva contraseña temporal y exige cambio en el siguiente acceso.

El Administrativo no puede modificar ni restablecer credenciales de una cuenta que posea rol Administrador general. Un Administrador general puede restablecer credenciales de cualquier usuario de Athleta, incluidos otros Administradores generales.

Las credenciales de Soporte Broco son administradas exclusivamente por Broco. Si no existe otro Administrador general disponible para recuperar el acceso de un Administrador general bloqueado, Soporte Broco puede intervenir como mecanismo excepcional.

El sistema no muestra la contraseña vigente en ningún momento. Los restablecimientos sensibles conservan quién ejecutó la acción y cuándo.

4.5 Gestión de usuarios por el Administrativo

El Administrativo puede gestionar normalmente los usuarios estándar del Equipo. Esto incluye crear usuarios, consultar y editar toda su ficha, asignar o quitar los roles Profesor, Kinesiólogo, Osteópata y Administrativo, activar o inactivar cuentas y restablecer contraseñas.

No puede crear, asignar, quitar ni modificar el rol Administrador general. Si una cuenta posee ese rol, queda protegida de su gestión.

4.6 Gestión por el Administrador general

El Administrador general puede gestionar todos los usuarios de Athleta, incluidos otros Administradores generales. No puede administrar las cuentas de Soporte Broco, que se mantienen bajo control de Broco Solutions.

4.7 Estado del usuario interno

Las cuentas internas utilizan estado Activo o Inactivo. Un usuario Inactivo pierde acceso al sistema, pero su identidad continúa asociada a los registros históricos que creó o modificó.

Los usuarios internos no se eliminan físicamente. La baja se resuelve mediante inactivación para preservar referencias históricas de rutinas, pagos, atenciones, evoluciones, tratamientos, gastos y demás registros. Las cuentas Inactivas no necesitan ocupar el listado operativo habitual, pero deben poder consultarse mediante un filtro y reactivarse cuando corresponda.

4.8 Inactivación con responsabilidades pendientes

No se permite inactivar a un profesional cuando todavía tiene responsabilidades operativas actuales que quedarían sin resolver.

Si un Profesor tiene alumnos asignados como Profesor principal, antes de inactivarlo deben reasignarse esos alumnos. El sistema muestra cuántos son, permite acceder al listado y facilita una reasignación masiva. La reasignación afecta únicamente la responsabilidad actual de Profesor principal: rutinas, evaluaciones físicas, pagos y demás registros previos conservan sus autores y referencias originales.

Si un Kinesiólogo u Osteópata tiene Tratamientos En curso o Turnos clínicos futuros Agendados asignados, esas responsabilidades deben resolverse o reasignarse antes de la inactivación. La reasignación no modifica autorías ni profesionales de la Historia Clínica previa.

La misma protección se aplica al quitar roles. No puede quitarse el rol Profesor mientras el usuario continúe como Profesor principal de Alumnos. Tampoco puede quitarse el último rol clínico mientras conserve Tratamientos En curso o Turnos clínicos futuros Agendados asignados. Si conserva otro rol clínico, la acción no se bloquea.

No se realizan reasignaciones automáticas. El equipo elige explícitamente el reemplazo.

4.9 Usuario interno que también es Alumno o Paciente

La cuenta del Equipo y la ficha de Persona son conceptos separados. Un Profesor, Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo o Administrador general puede tener además una Persona propia si utiliza servicios de Athleta.

No existe vinculación automática de credenciales. El usuario interno accede con email y contraseña; como Alumno o Paciente accede al Portal con DNI y PIN.

El DNI opcional de la ficha del Equipo puede coincidir con el DNI de una Persona. La unicidad del DNI se controla entre Personas, no entre Personas y cuentas del Equipo.

> **Ejemplo:** Un Profesor que recibe tratamiento de Kinesiología tiene una cuenta interna para trabajar y una ficha de Paciente para su atención. Su información clínica se rige por las mismas reglas de privacidad que la de cualquier otra Persona.

5. Personas: identidad, ficha y ciclo de vida

5.1 Registro único

Toda relación con Athleta se construye sobre una única Persona. Antes de crear una nueva, el sistema verifica el DNI y orienta a utilizar la ficha existente cuando corresponda.

Si una Persona ya existe como Alumno y luego necesita Clínica, se la da de alta como Paciente sobre la misma ficha. Del mismo modo, un Paciente que comienza a entrenar se incorpora a Sala sobre esa misma Persona. Nunca se crea una segunda identidad por cambiar o sumar un área.

El DNI es obligatorio y único entre Personas.

5.2 Datos generales

Los datos generales mínimos de una Persona son Nombre, Apellido, DNI, Teléfono y Fecha de nacimiento. El alta también se realiza desde un contexto de ingreso -Sala o Clínica- para orientar el flujo posterior.

Son opcionales Email, nombre y teléfono de contacto de emergencia, Obra social y número de afiliado. Profesor, Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo y Administrador general pueden crear Personas y corregir sus datos generales dentro de sus tareas habituales.

No se utiliza la ficha general para guardar domicilio, CUIT, profesión, notas médicas generales ni información clínica extensa. La información clínica se documenta en la Historia Clínica.

5.3 Incorporación a Sala

La incorporación a Sala puede realizarse sobre una Persona nueva o sobre una Persona ya existente, por ejemplo un Paciente.

Para participar de Sala se requieren obligatoriamente Profesor principal y Plan. Si la Persona ya existe, se reutilizan sus datos generales y solo se completan o corrigen los que correspondan junto con esas dos asignaciones.

La incorporación a Sala convierte a la Persona en Alumno y la vuelve Activa. Si se está creando una Persona nueva, en ese momento se genera también su PIN inicial del Portal; si la Persona ya existía, conserva sus credenciales actuales.

5.4 Alta como Paciente

La condición de Paciente se obtiene mediante un alta explícita en Clínica. El alta puede crear una Persona nueva o reutilizar una Persona que ya existe por Sala u otro vínculo.

Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo y Administrador general pueden dar de alta a una Persona como Paciente. Cuando la Persona ya existe, el sistema recupera sus datos generales y solicita únicamente completar o corregir lo necesario. El alta como Paciente no crea una segunda ficha ni un nuevo PIN.

Dar de alta como Paciente no obliga a crear un Tratamiento, un Turno, una Atención ni a definir un profesional responsable general. Después del alta, el equipo realiza la acción que corresponda.

Un Paciente puede permanecer Inactivo si todavía no participa de Sala, no tiene Tratamientos En curso y no posee Turnos clínicos futuros Agendados. Su condición de Paciente se conserva históricamente.

5.5 PIN de Portal generado al alta

Al crear una Persona por primera vez, el sistema genera automáticamente un PIN aleatorio numérico de cuatro dígitos. Incorporar a Sala o dar de alta como Paciente a una Persona ya existente no genera un PIN nuevo.

El PIN inicial no vence por tiempo. Se muestra una vez al finalizar la creación de la Persona para que el usuario interno pueda comunicarlo manualmente. Después de abandonar esa confirmación, el PIN vigente no vuelve a mostrarse.

En el primer acceso al Portal, la Persona debe cambiar el PIN. Si lo olvida, cualquier usuario interno puede restablecerlo; el sistema genera otro PIN temporal aleatorio, lo muestra una vez y exige cambio en el siguiente acceso.

La existencia de un PIN no habilita el Portal por sí sola. Una Persona Inactiva no puede ingresar.

5.6 Ficha unificada

La ficha de Persona es única y se presenta de forma contextual. En su encabezado debe permitir identificar rápidamente Nombre, DNI, estado general y relación con Sala, Clínica o ambas.

La información puede organizarse en secciones como Datos, Sala y Clínica, mostrando únicamente aquellas a las que el usuario tenga permiso. Las acciones frecuentes se ubican cerca del contexto correspondiente; por ejemplo, Registrar pago dentro de Sala y Agendar turno o Registrar atención dentro de Clínica.

La ficha no debe convertirse en una página interminable donde se mezclen pagos, rutinas, tratamientos y evoluciones sin jerarquía.

5.7 Estado Activo/Inactivo automático

El estado general se deriva de la actividad vigente. La Persona es Activa si participa de Sala, tiene al menos un Tratamiento clínico En curso o posee al menos un Turno clínico futuro Agendado.

Un Turno deja de considerarse futuro al llegar su hora de inicio. Si continúa Agendado porque nadie actualizó su estado, permanece visible como Turno pendiente de actualización, pero ya no sostiene por sí solo el estado Activo.

Cuando termina la última actividad vigente, el estado pasa automáticamente a Inactivo. Cuando aparece una nueva actividad vigente, vuelve a Activo.

Ejemplo: una Persona deja Sala pero conserva un Tratamiento En curso. Continúa Activa. Cuando ese Tratamiento finaliza y no tiene Turnos clínicos futuros Agendados, pasa a Inactiva.

Ejemplo: una Paciente histórica Inactiva agenda una consulta para la semana siguiente. El Turno futuro Agendado la vuelve Activa y habilita el Portal para consultarlo.

5.8 Inactivación global deliberada

Además del comportamiento automático, Administrativo y Administrador general pueden ejecutar la acción explícita “Inactivar persona” cuando se necesita finalizar de manera global la relación operativa.

La inactivación tiene efecto desde el momento de la confirmación y no es retroactiva. Las actividades cuya hora de inicio ya ocurrió se preservan tal como están y pueden corregirse posteriormente según sus reglas normales.

Al confirmar, la Persona deja Sala; se finalizan sus turnos fijos desde ese momento; se cancelan las reservas futuras de Sala; los Tratamientos clínicos En curso se finalizan con motivo Interrupción; se cancelan los Turnos clínicos futuros Agendados; y se bloquea el Portal. La historia previa permanece intacta.

Antes de confirmar, el sistema resume el impacto concreto e informa cantidades relevantes. No modifica ni cancela actividades ya iniciadas o realizadas.

5.9 Reactivación

La Persona vuelve a Activa cuando aparece una nueva actividad vigente. No existe un proceso independiente de “reactivar” que restaure automáticamente relaciones antiguas.

Si vuelve a Sala, se realiza un nuevo ingreso a Sala con Profesor principal y Plan. No se restauran rutina activa, turnos fijos ni indicaciones clínicas antiguas.

Si se agenda un Turno clínico futuro o se reabre/comienza un Tratamiento, el estado general se actualiza a Activo.

5.10 Eliminación de una Persona creada por error

La eliminación definitiva existe únicamente para corregir un alta equivocada antes de que la Persona haya generado historia real. Puede realizarla cualquier usuario interno.

No impiden la eliminación los datos generales, Obra social y número de afiliado, contacto de emergencia, PIN, el alta inicial como Paciente ni la incorporación inicial a Sala con Plan, Profesor principal y Objetivo de Sala.

Impiden la eliminación los siguientes registros: Turnos fijos de Sala; reservas puntuales o asistencias; rutinas; evaluaciones físicas; Pagos de Sala; Turnos clínicos; Atenciones; Evoluciones; Evaluaciones clínicas; Tratamientos; Estudios o archivos clínicos; antecedentes clínicos; Indicaciones para Sala; Órdenes de obra social; Ingresos clínicos; y análisis de IA guardados.

Si un registro fue creado por error y sus propias reglas permiten eliminarlo, puede corregirse o eliminarse primero. La Persona vuelve a ser eliminable únicamente si después no queda ningún registro bloqueante.

La eliminación requiere una confirmación simple que muestre claramente Nombre y DNI. No se solicita motivo ni doble confirmación.

5.11 Listados de Alumnos y Pacientes

El listado Alumnos muestra por defecto a quienes participan actualmente de Sala. Las Personas que dejaron Sala pueden encontrarse mediante filtros cuando sea necesario consultar su historia.

El listado Pacientes muestra a todas las Personas que fueron dadas de alta en Clínica, independientemente de que tengan un Tratamiento activo o actividad clínica reciente. Dar de alta como Paciente incorpora inmediatamente a la Persona a este listado.

Pacientes muestra de manera visible la última Atención o el texto “Sin atenciones”, además del estado general Activo/Inactivo. Permite filtrar por Tratamiento En curso Sí/No y por períodos sin Atención de 30, 60 y 90 o más días.

5.12 Búsqueda global

Desde cualquier parte del sistema interno debe existir una búsqueda rápida de Personas por Nombre o DNI. La búsqueda global está orientada a encontrar Personas, no a buscar texto libre dentro de pagos, evoluciones o archivos.

Cada resultado muestra la información mínima necesaria para distinguir a la Persona: Nombre, DNI, estado Activo/Inactivo y relación con Sala, Clínica o ambas. No expone diagnósticos, pagos ni información clínica sensible.

Al seleccionar el resultado se abre la ficha unificada respetando los permisos del usuario.

6. Sala

6.1 Participación en Sala

La participación en Sala es una condición específica e independiente del estado general de la Persona. Se expresa como participa/no participa actualmente de Sala.

Una Persona que participa en Sala debe tener obligatoriamente un Profesor principal y un Plan. No existe participación activa de Sala sin esas dos asignaciones.

Profesor, Administrativo y Administrador general pueden incorporar una Persona a Sala, cambiar su Profesor principal, cambiar su Plan o darla de baja de Sala.

6.2 Baja de Sala

La baja de Sala es inmediata y afecta únicamente a la relación con Sala. No elimina la Persona ni modifica por sí sola su Historia Clínica.

Al dar de baja de Sala se finalizan los turnos fijos de Sala, se cancelan las reservas puntuales futuras, la rutina activa pasa a histórica y se cierran las indicaciones clínicas activas destinadas a Sala. Se conservan pagos, asistencias, evaluaciones físicas, rutinas históricas y demás información previa.

También dejan de existir como asignaciones actuales el Plan y el Profesor principal. No se mantiene un historial específico de cambios de Profesor o Plan más allá de la información histórica que naturalmente quede asociada a los registros realizados.

La baja utiliza una confirmación simple que informa la cantidad de elementos afectados cuando corresponda. No exige motivo ni una segunda confirmación.

> **Ejemplo:** Si un Alumno tiene dos turnos fijos, tres reservas puntuales futuras y una rutina activa, la confirmación de baja debe informar esos impactos. Al confirmar, se termina su participación en Sala, pero un Tratamiento clínico que pudiera tener continúa normalmente.

6.3 Reingreso a Sala

El reingreso se realiza sobre la misma Persona. Se vuelve a seleccionar un Profesor principal y un Plan. No se restauran automáticamente el Profesor anterior, Plan anterior, turnos fijos, reservas, rutina activa ni indicaciones clínicas cerradas.

Los meses en los que la Persona estuvo fuera de Sala no se consideran deuda ni meses impagos. El control de meses consecutivos sin pago se calcula únicamente dentro del período actual de participación.

> **Ejemplo:** Una Persona deja Sala en marzo y vuelve en agosto. Agosto inicia una nueva situación de pago. Abril, mayo, junio y julio no aparecen como deuda por no haber participado de Sala.

6.4 Profesor principal

Cada Alumno tiene un único Profesor principal mientras participa de Sala. La asignación sirve para organizar el seguimiento y alimentar filtros como “Mis alumnos”. No impide que otros Profesores consulten o trabajen con el Alumno.

Profesor, Administrativo y Administrador general pueden cambiar el Profesor principal directamente. No existe aprobación, motivo obligatorio ni historial específico del cambio.

Cambiar el Profesor principal no modifica rutinas, evaluaciones físicas, turnos, Plan, pagos ni autorías históricas.

6.5 Cambio masivo de Profesor principal

El listado de Alumnos admite selección mediante casillas cuando existe una acción masiva real. Una de esas acciones es Cambiar profesor principal.

La selección puede abarcar uno, varios o todos los alumnos que cumplen los filtros actuales, incluso si el listado está paginado. Antes de aplicar el cambio se confirma la cantidad de alumnos afectados.

6.6 Configuración horaria habitual de Sala

Sala posee una grilla semanal habitual que representa los horarios en los que se puede entrenar. Cada horario se define por día de la semana, hora de inicio, duración y capacidad.

Al crear un horario, la duración propuesta es de 60 minutos y puede modificarse libremente. La hora de finalización se deriva de la hora de inicio y la duración. La interfaz favorece el caso habitual de bloques de una hora y horarios redondos, sin convertirlo en una restricción.

Dentro de un mismo día no se permiten horarios habituales que se superpongan. Un horario puede comenzar exactamente cuando finaliza el anterior.

La grilla habitual no requiere una fecha de finalización y continúa vigente hasta que se realiza un cambio permanente. Profesor, Administrativo y Administrador general pueden modificarla.

6.7 Capacidad general y capacidad por horario

Sala posee una capacidad general configurable. Cada horario de la grilla puede heredar esa capacidad o definir una capacidad específica.

Cuando se modifica la capacidad general, el cambio afecta a los horarios que continúan heredándola. Los horarios con capacidad propia mantienen su valor.

Si una capacidad general o específica se reduce por debajo de las reservas ya existentes, esas reservas se conservan. El sistema advierte el sobrecupo resultante; el Portal no permite nuevas reservas mientras no exista lugar disponible y los usuarios internos mantienen la posibilidad de operar deliberadamente con sobrecupo.

La agenda distingue siempre entre capacidad, reservas y asistencias. Si existe sobrecupo por una decisión interna, la información debe seguir siendo visible y no ocultarse mediante un ajuste artificial de la capacidad.

6.8 Cambios permanentes de la grilla

Un cambio permanente puede definirse con una fecha desde la cual comienza a regir. La configuración anterior se conserva como historia necesaria para interpretar reservas y asistencias pasadas.

Mientras se mantengan el mismo día de la semana y la misma hora de inicio, se considera que continúa siendo el mismo horario. Cambiar capacidad o duración no termina los Turnos fijos ni cancela reservas existentes.

Cambiar el día o la hora de inicio, o eliminar permanentemente el horario, se considera un reemplazo. Desde la fecha de vigencia terminan los Turnos fijos afectados y se cancelan las reservas puntuales futuras correspondientes. Antes de confirmar se informa la cantidad de Personas afectadas.

El sistema nunca reasigna automáticamente a otro horario. Si solo se reduce la capacidad y quedan más reservas que cupos, las reservas se conservan y el horario queda en sobrecupo según las reglas normales.

6.9 Excepciones por fecha

Además de la grilla habitual, se pueden registrar excepciones para una fecha concreta. Una excepción permite cerrar un horario de ese día o cambiar su capacidad únicamente para esa ocurrencia.

Cerrar una fecha con reservas existentes requiere mostrar las reservas afectadas y cancelar únicamente esa ocurrencia. El turno fijo semanal continúa en las semanas siguientes.

Reducir la capacidad de una fecha por debajo de la cantidad ya reservada no elimina reservas existentes. El sistema advierte la situación; desde el Portal no se permiten nuevas reservas, mientras que internamente se conserva la posibilidad de sobrecupos deliberados.

6.10 Turno fijo semanal

Un Alumno puede tener uno o varios Turnos fijos semanales. Cada Turno fijo se define por un horario habitual de Sala, una Fecha de inicio y una Fecha de finalización opcional.

Al crearlo, el sistema propone como Fecha de inicio la próxima ocurrencia del horario elegido. La Fecha de inicio puede modificarse por una fecha futura, pero no puede ser anterior al momento de creación; los Turnos fijos no reconstruyen ocurrencias retroactivas.

La Fecha de finalización queda por defecto como “Sin fecha de finalización” y puede completarse cuando ya se conoce hasta cuándo debe mantenerse la recurrencia. El Turno continúa hasta esa fecha o hasta que sea finalizado antes.

No existe un máximo funcional de Turnos fijos por Alumno ni se valida la frecuencia contratada según el Plan.

Profesor, Administrativo y Administrador general pueden crear, cambiar o finalizar Turnos fijos. También pueden hacerlo aunque el horario esté completo, con advertencia previa de sobrecupo. El Alumno puede gestionar sus propios Turnos fijos desde el Portal, siempre sujeto a capacidad disponible.

6.11 Cancelación de una ocurrencia

Cancelar una ocurrencia concreta derivada de un turno fijo no elimina ni modifica la recurrencia semanal. Solo afecta esa fecha. Profesor, Administrativo y Administrador general pueden realizar la cancelación desde la operación interna. El Alumno también puede cancelar desde el Portal una ocurrencia de su propio turno fijo hasta el momento de inicio del horario; después de ese momento, el estado queda bajo gestión interna.

Esta separación permite que una ausencia o cancelación puntual no obligue a reconstruir el turno habitual del Alumno. Por ejemplo, si un Alumno tiene un turno fijo todos los lunes a las 18:00 y cancela únicamente el próximo lunes, la recurrencia continúa normalmente desde la semana siguiente.

6.12 Reserva puntual

La reserva puntual permite registrar un horario de Sala para una fecha específica sin relacionarlo con recuperos, créditos ni compensaciones de asistencias.

Desde el Portal se pueden reservar horarios dentro de una ventana móvil de los próximos 30 días y hasta el momento de inicio. La Persona debe estar Activa, participar de Sala y existir capacidad disponible.

Profesor, Administrativo y Administrador general pueden crear reservas puntuales sin un límite temporal futuro específico y también registrar o corregir ocurrencias de fechas pasadas. Cuando trabajan sobre una fecha ya transcurrida, pueden registrar directamente el estado de asistencia que corresponda.

El Plan no limita la cantidad de reservas ni funciona como saldo de clases. No existe un balance de recuperos.

6.13 Capacidad y sobrecupo

El Portal nunca permite superar la capacidad disponible. Para el Alumno la disponibilidad se comunica como “Hay lugar” o “Sin lugar”.

Los usuarios internos sí pueden generar deliberadamente un sobrecupo al crear o modificar un Turno fijo, registrar una reserva puntual o incorporar espontáneamente a un Alumno. Antes de confirmar se muestra una advertencia no bloqueante.

Las reservas y Turnos fijos ya existentes se conservan si una capacidad se reduce posteriormente. Mientras el horario permanezca completo o sobreocupado, el Portal no admite nuevas reservas ni modificaciones que requieran un nuevo cupo.

6.14 Duplicados de reserva

Una Persona no puede estar registrada dos veces para la misma fecha y el mismo horario de Sala. Sí puede asistir a otro horario de esa misma fecha.

6.15 Estados de asistencia de Sala

Cada ocurrencia operativa de Sala utiliza los estados Reservado, Asistió, Cancelado o Ausente.

Profesor, Administrativo y Administrador general pueden corregir el estado posteriormente sin límite de tiempo. También pueden incorporar a un Alumno en una fecha pasada y registrar directamente el estado correcto de esa ocurrencia.

No se utiliza eliminación física de una asistencia histórica como mecanismo habitual. La corrección conserva únicamente la trazabilidad mínima que corresponda al registro, sin exigir motivo ni mantener un historial completo de versiones.

Las reservas pasadas que nunca fueron actualizadas permanecen Reservado hasta que el equipo las corrija. No existe cambio automático a Ausente ni cierre diario obligatorio.

6.16 Vista operativa diaria

La agenda diaria de Sala está orientada al trabajo del día. Debe permitir recorrer Hoy, Mañana u otra fecha y mostrar los horarios con capacidad, cantidad reservada y asistencias.

Dentro de cada horario se listan los alumnos del turno y se identifica el origen de su presencia: Turno fijo, reserva puntual o incorporación espontánea. También se muestra el estado de asistencia, la señal de Pago pendiente cuando corresponda y el indicador clínico de Sala si existe una indicación activa.

A efectos de los indicadores del Inicio, “Alumnos esperados” cuenta únicamente Turnos fijos y reservas puntuales. Una incorporación espontánea registrada como Asistió incrementa las Asistencias registradas, pero no modifica retroactivamente la cantidad de esperados.

La vista diaria y la configuración de la grilla semanal son contextos distintos: operar asistencias no debe mezclarse con editar permanentemente los horarios.

6.17 Incorporación espontánea

Profesor, Administrativo y Administrador general pueden agregar a un Alumno espontáneamente al horario actual y marcar su asistencia. Si el horario está completo, se aplica la advertencia de sobrecupo sin bloquear la acción.

6.18 Acciones masivas sobre Alumnos

Las acciones masivas se limitan a aquellas que tienen un beneficio operativo real: Dar de baja de Sala y Cambiar profesor principal. Para ambas, el usuario puede seleccionar uno, varios o todos los alumnos que cumplen los filtros actuales, incluso cuando el listado está paginado.

No se agregan acciones masivas genéricas para cambiar Plan, registrar pagos, modificar rutinas o cerrar otras relaciones. La selección múltiple solo aparece cuando existe una acción aplicable.

6.19 Filtro por meses consecutivos sin pago

El listado de Alumnos permite filtrar por cantidad de meses consecutivos sin pago, con opciones prácticas de 1 o más, 2 o más, 3 o más y 6 o más meses.

El filtro es una herramienta para revisión manual. No produce baja automática, inactivación, bloqueo de reservas ni ninguna otra consecuencia por sí solo.

La secuencia se evalúa únicamente dentro de la participación actual de Sala. El mes de incorporación cuenta desde el momento en que la Persona ingresa a Sala: si todavía no existe un Pago válido para ese Mes/Año, ese mes ya constituye el primer mes impago.

Los meses anteriores a un reingreso no se arrastran como deuda.

6.20 Rutina activa

Cada Alumno puede tener como máximo una única Rutina activa. Cuando se crea una nueva Rutina y se establece como vigente, la anterior pasa a histórica.

Tener una Rutina activa no es requisito para participar de Sala, reservar, asistir ni utilizar el Portal. Los Alumnos sin Rutina activa se identifican para facilitar el seguimiento, sin bloqueo ni plazo obligatorio.

Profesor y Administrador general pueden crear, modificar y reemplazar Rutinas. El Administrativo puede consultarlas, pero no diseñarlas salvo que además posea rol Profesor.

6.21 Estructura de una rutina

Una Rutina contiene uno o más días de entrenamiento identificados de manera simple como Día 1, Día 2, Día 3, etc. Los días no se vinculan obligatoriamente a días de la semana y no existe un máximo funcional establecido.

Cada fila de ejercicio requiere seleccionar un Ejercicio. Series, Repeticiones o Tiempo, Carga, Descanso y Observación son opcionales y se completan únicamente cuando aportan valor para esa prescripción.

Repeticiones y Tiempo son alternativas dentro de un mismo ejercicio. Tiempo, Carga y Descanso se expresan como texto breve con la unidad o referencia necesaria, por ejemplo “30 seg”, “80 kg”, “peso corporal” o “2 min”. No existe catálogo de unidades ni cálculos automáticos.

La Rutina no utiliza bloques, fases, superseries, cálculos automáticos ni estructuras de periodización avanzadas.

6.22 Edición de rutina

La Rutina activa se edita directamente y se guarda mediante una acción explícita. No existen borradores, publicación, aprobación ni autosave general.

Puede crearse una Rutina desde cero o duplicando una Rutina activa o histórica. Duplicar precarga días, ejercicios, valores y observaciones como punto de partida para una nueva Rutina independiente; la original no se modifica.

Si una Rutina histórica contiene un Ejercicio que ya fue retirado del catálogo, al duplicarla ese Ejercicio se identifica como no disponible y debe quitarse o reemplazarse antes de guardar la nueva Rutina.

Cuando se reemplaza la Rutina vigente, la anterior queda disponible como historia interna. Las Rutinas históricas no se muestran en el Portal.

6.23 Catálogo de ejercicios

Sala utiliza un catálogo simple de Ejercicios para agilizar la carga de Rutinas. Cada Ejercicio tiene Nombre obligatorio, Músculo principal opcional y Descripción opcional.

Todo Ejercicio de una Rutina proviene de este catálogo. Si el Profesor necesita uno que todavía no existe, puede crearlo desde la propia carga de la Rutina y continuar trabajando sin salir del flujo.

El catálogo no incluye videos, imágenes ni estado Activo/Inactivo. Profesor y Administrador general pueden crear, modificar y retirar Ejercicios.

Editar Nombre, Músculo principal o Descripción actualiza el mismo concepto y las Rutinas que lo utilizan muestran la definición actual. Si se trata de otro ejercicio, se crea uno nuevo.

Si se intenta retirar un Ejercicio presente en Rutinas activas, el sistema informa cuántas serán afectadas. Al confirmar, el Ejercicio se quita también de esas Rutinas activas. Las Rutinas históricas nunca se modifican.

6.24 Seguimiento de rutina en el Portal

El Alumno consulta su rutina activa en modo lectura. Ve todos los días de la rutina y el detalle de cada ejercicio.

No registra ejercicios completados, peso efectivamente utilizado, comentarios, checklists de sesión ni progresión de cargas desde el Portal.

6.25 Objetivo de Sala

La ficha de Sala incluye un campo Objetivo breve y opcional del Alumno. Profesor y Administrador general pueden modificarlo; el Administrativo puede consultarlo.

Este objetivo es una referencia simple para entrenamiento y no sustituye información clínica.

6.26 Evaluaciones físicas de Sala

Las Evaluaciones físicas de Sala son independientes de las Evaluaciones clínicas. Se enfocan en rendimiento físico, principalmente Fuerza y Movilidad, sin constituir Historia Clínica ni un módulo de antropometría o nutrición.

Cada Evaluación registra Fecha, Profesor, uno o más Tests con sus Resultados y una Observación general opcional. La estructura se mantiene abierta para reflejar distintas formas de evaluación sin exigir modelos específicos de fuerza, movilidad o medición.

6.27 Catálogo de tests físicos

El catálogo de Tests físicos utiliza Nombre obligatorio, Tipo y Descripción opcional. El Tipo puede ser Fuerza, Movilidad u Otra.

Profesor y Administrador general pueden crear, modificar y retirar Tests. También pueden crear un Test durante la carga de una Evaluación si todavía no existe.

Los Tests no utilizan estado Activo/Inactivo. Retirar un Test impide seleccionarlo en nuevas Evaluaciones, pero no modifica las Evaluaciones históricas que ya lo utilizaron.

Editar Nombre, Tipo o Descripción actualiza el mismo Test; no existe versionado. Si se quiere representar una evaluación conceptualmente distinta, se crea otro Test.

6.28 Resultados de tests físicos

Cada uso de un Test registra un Resultado breve en formato abierto. El Profesor expresa allí la medida o hallazgo con la unidad o referencia que corresponda, por ejemplo “100 kg x 5 repeticiones”, “160°”, “48 cm” o “Positivo”.

Una misma Evaluación puede incluir el mismo Test más de una vez cuando el Profesor lo necesite. El sistema no intenta interpretar, calcular ni clasificar automáticamente los Resultados.

No existen niveles, puntuaciones, cálculo automático de 1RM ni conversiones de unidades.

6.29 Corrección y consulta de evaluaciones físicas

Profesor y Administrador general pueden crear y corregir Evaluaciones físicas. No se eliminan físicamente como operación habitual. El Administrativo puede consultarlas.

Las correcciones se realizan directamente, sin historial de versiones ni trazabilidad adicional de último modificador. La Evaluación conserva su Fecha y Profesor.

El Alumno puede consultar sus Resultados desde el Portal. La evolución se presenta de forma simple y cronológica por Test, sin dashboards ni gráficos avanzados.

6.30 Planes de Sala

Los Planes son referencias comerciales y de precio. No controlan la cantidad de asistencias ni limitan reservas.

Cada Plan tiene Nombre, Precio actual y Descripción opcional. El nombre puede expresar una modalidad comercial como “2 veces por semana”, pero el sistema no utiliza ese texto para validar frecuencia.

Administrativo y Administrador general gestionan el catálogo. Profesor puede asignar o cambiar el Plan de un Alumno, pero no administrar el catálogo.

Los Planes no utilizan estado Activo/Inactivo. Un Plan asignado actualmente no puede retirarse. Cuando ya no está asignado a ningún Alumno puede retirarse del catálogo y deja de estar disponible para nuevas asignaciones. Si en el futuro Athleta vuelve a necesitarlo, se crea un Plan nuevo.

Editar el Nombre, Precio actual o Descripción actualiza el mismo Plan; no existe historial de nombres ni de precios. Los movimientos históricos conservan sus datos propios, especialmente el importe efectivamente cobrado.

6.31 Cambio de Plan

Profesor, Administrativo y Administrador general pueden cambiar directamente el Plan de un Alumno. El cambio es inmediato y no crea períodos, prorrateos ni fechas de vigencia adicionales.

Un pago ya registrado no cambia por modificar el Plan. Los próximos pagos proponen el precio actual del nuevo Plan.

6.32 Precio actual

El Plan conserva únicamente su precio actual. No se mantiene una tabla de historia de precios.

Los pagos ya registrados conservan el importe efectivamente cobrado. Si en un mes se necesita cobrar un precio anterior o un valor especial, el usuario puede modificar el importe propuesto y registrar el Motivo de ajuste.

6.33 Pago mensual de Sala

Mientras una Persona participa en Sala, se espera un Pago por Alumno y por Mes/Año. El mes de incorporación queda pendiente desde el momento en que comienza la participación si todavía no existe un Pago válido para ese mes.

No existen pagos parciales ni múltiples Pagos válidos para el mismo Alumno y Mes/Año. Si se cobran varios meses juntos, cada mes se registra como un movimiento independiente.

El Mes/Año que se paga puede corresponder a un mes pasado, actual o futuro. La deuda no bloquea Agenda, reservas, Portal ni otras funcionalidades.

El Importe de un Pago debe ser mayor a cero. No se registran Pagos negativos ni existe lógica de devolución/reversión dentro de Athleta Manager.

6.34 Datos del pago de Sala

Cada Pago registra Mes/Año, Fecha real de cobro, Importe, Medio de pago y Usuario que lo registró. La Fecha real de cobro representa cuándo Athleta recibió efectivamente el dinero y debe ser hoy o una fecha anterior, nunca futura.

Al iniciar la carga, el Importe propone el Precio actual del Plan. Si se modifica respecto del valor propuesto, se exige un Motivo de ajuste breve porque existe una diferencia económica concreta.

Pagar anticipadamente un Mes/Año futuro no cambia el criterio financiero: Finanzas ubica el movimiento en la Fecha real de cobro, mientras el estado mensual del Alumno utiliza el Mes/Año pagado.

6.35 Permisos sobre pagos de Sala

Profesor, Administrativo y Administrador general pueden registrar, corregir y eliminar pagos de Sala. La eliminación es definitiva y utiliza una confirmación simple.

Si se elimina el único pago válido del mes de un Alumno que continúa participando de Sala, su estado vuelve naturalmente a Pago pendiente.

Si una Persona deja Sala y reingresa dentro del mismo Mes/Año, un Pago de Sala válido ya registrado para ese mes continúa siendo válido y no se exige un segundo pago. Si todavía no existía un pago válido para ese mes, al reingresar figura Pago pendiente según la regla normal.

Los movimientos económicos eliminados no utilizan estado Anulado ni se conservan como registros visibles anulados.

6.36 Medio de pago

Los Pagos de Sala utilizan un catálogo compartido de Medios de pago. Administrativo y Administrador general gestionan el catálogo; los demás roles habilitados solo seleccionan valores disponibles.

Los Medios de pago no utilizan estado Activo/Inactivo. Un valor retirado deja de estar disponible para nuevos movimientos, pero los registros históricos continúan mostrando la referencia utilizada.

6.37 Estado de pago en Portal

El Portal muestra únicamente el estado del mes actual: “Pago registrado” o “Pago pendiente”. No muestra importe, historial de pagos, cuenta corriente, meses anteriores ni deuda futura.

6.38 Indicaciones clínicas visibles en Sala

Sala recibe únicamente la información clínica necesaria para entrenar de forma segura. La tarjeta clínica muestra si existe Tratamiento En curso y presenta las Indicaciones activas destinadas a Sala.

Cada Indicación tiene una Condición de entrenamiento obligatoria: Sin restricciones, Con restricciones o No entrenar. Zona afectada es siempre opcional. Instrucciones son obligatorias únicamente cuando la Condición es Con restricciones; en los otros dos casos son opcionales.

La Indicación comienza a estar vigente al crearse y permanece activa hasta que se cierra. No utiliza una Fecha de inicio adicional ni una Fecha de finalización programada.

No se muestran diagnósticos, Estudios, Evoluciones, Evaluaciones clínicas ni detalles terapéuticos completos.

6.39 Varias indicaciones simultáneas

Puede existir más de una indicación activa para Sala, incluso asociada a distintos Tratamientos o sin Tratamiento. La interfaz muestra cada indicación por separado, con su condición e instrucciones, para que el Profesor pueda comprender todas las indicaciones vigentes sin aplicar reglas automáticas de prioridad entre ellas.

6.40 Cierre de una indicación desde Sala

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general crean y modifican el contenido de las Indicaciones para Sala. Cualquier usuario interno puede cerrarlas cuando confirma operativamente que ya no corresponde mostrarlas como activas.

El cierre desde un rol no clínico no permite editar la Indicación ni acceder a Historia Clínica. Requiere una advertencia breve y conserva quién la cerró y cuándo.

Una Indicación cerrada no se reabre. Si vuelve a ser necesaria, se crea una nueva Indicación para que la historia conserve períodos claramente diferenciados.

6.41 Relación entre baja de Sala e indicaciones

Al dar de baja de Sala se cierran automáticamente las indicaciones activas destinadas a Sala. La información queda en la historia, pero un eventual reingreso comienza sin restricciones antiguas activadas automáticamente.

7. Clínica: Kinesiología y Osteopatía

7.1 Clínica como unidad funcional

Kinesiología y Osteopatía funcionan dentro de una única área Clínica. Comparten Pacientes, Historia Clínica, agenda, tratamientos, evaluaciones, estudios, biblioteca, IA, órdenes e ingresos. La profesión del profesional que interviene se conserva en cada registro cuando corresponde, pero no existen dos circuitos clínicos separados.

7.2 Paciente y vínculo clínico

Una Persona se considera Paciente cuando fue dada de alta explícitamente en Clínica. El alta puede realizarse sobre una Persona nueva o sobre una Persona que ya existía por Sala.

La condición de Paciente se conserva históricamente aunque no tenga Tratamientos En curso, Turnos futuros ni actividad clínica reciente. El listado de Pacientes no representa por sí solo el estado general de la Persona.

Cada fila debe mostrar claramente Activo/Inactivo y la fecha de Última atención o “Sin atenciones”.

7.3 Historia Clínica

La Historia Clínica concentra la información clínica relevante de la Persona. Está disponible para Kinesiólogos, Osteópatas y Administrador general. Los profesionales clínicos pueden consultar la historia completa de cualquier Paciente, no únicamente de aquellos cuyos Tratamientos tengan asignados.

El Administrativo no ingresa a la Historia Clínica. Su operación clínica se limita a agenda, órdenes, ingresos, datos generales y registro de actividad sin contenido clínico.

El Profesor tampoco accede a Historia Clínica completa. Recibe únicamente indicaciones expresamente destinadas a Sala.

7.4 Organización de la Historia Clínica

La Historia Clínica debe permitir comprender primero la situación actual y luego profundizar en el pasado. No debe presentar una única secuencia indiscriminada de turnos, pagos, archivos y cambios administrativos.

Puede organizarse en secciones como Resumen, Atenciones/Evoluciones, Evaluaciones, Tratamientos, Estudios y archivos y Antecedentes. La implementación visual exacta puede variar, pero deben mantenerse separados los grupos conceptuales para que el profesional encuentre rápidamente la información relevante.

El resumen clínico prioriza Tratamientos en curso, antecedentes relevantes, indicaciones activas para Sala y actividad reciente.

7.5 Antecedentes clínicos generales

La Historia Clínica permite registrar de forma opcional y simple Alergias, Medicación actual y Antecedentes relevantes en texto libre. No se utiliza un formulario médico exhaustivo.

La lesión, diagnóstico, motivo de consulta u objetivo actual se documentan en el Tratamiento, Atención o Evaluación que corresponda, en lugar de acumularse como notas generales sin contexto.

Kinesiólogos, Osteópatas y Administrador general pueden consultar y actualizar antecedentes. Profesor solo recibe las indicaciones para Sala; Administrativo no accede a esta sección.

7.6 Diferencia entre Turno, Atención, Evolución, Evaluación y Tratamiento

Concepto	Uso
Turno clínico	Planificación de una consulta en la agenda Clínica.
Atención	Registro de que la consulta efectivamente ocurrió.

Concepto	Uso
Evolución	Documentación narrativa de lo sucedido durante una Atención.
Evaluación clínica	Registro estructurado de tests y hallazgos, siempre asociado a una Atención.
Tratamiento clínico	Proceso de seguimiento opcional que agrupa el problema y puede relacionar múltiples Atenciones.

Estas entidades no se fuerzan entre sí más de lo necesario. Puede existir una Atención sin Turno previo y una Atención sin Tratamiento. En cambio, toda Evolución y toda Evaluación clínica pertenecen a una Atención porque documentan lo ocurrido en una consulta real.

7.7 Turno clínico

El Turno clínico organiza la agenda. Se registra para una Persona, una fecha y hora, una duración y un profesional específico. Puede incluir una nota operativa breve, que no se utiliza para documentar diagnóstico ni contenido clínico detallado.

El Turno no se asocia a Tratamientos. Su propósito es únicamente representar cuándo y con qué profesional está planificada una consulta. La relación con un Tratamiento, si corresponde, se define posteriormente en la Atención.

Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo y Administrador general pueden crear y gestionar Turnos. Se agendan individualmente para fechas futuras y no utilizan recurrencia. Si una consulta ya ocurrió sin Turno previo, se registra una Atención directa en lugar de crear un Turno retrospectivo.

La agenda Clínica prioriza una vista diaria con hora, Paciente, profesional y estado. En escritorio ofrece también una vista semanal para planificación. En móvil se prioriza la vista diaria.

7.8 Duración y solapamientos

Al crear un Turno clínico, el sistema propone una duración de 60 minutos para Kinesiología y Osteopatía. El usuario puede modificarla libremente en cada caso.

La duración debe ser mayor a cero, sin mínimo ni máximo funcional adicional. Los Turnos pueden comenzar en cualquier minuto; la interfaz puede facilitar horarios habituales sin imponer una granularidad obligatoria.

Se permiten Turnos superpuestos. Cuando el profesional ya tiene otros Turnos que se cruzan en el tiempo, el sistema muestra una advertencia no bloqueante e informa la cantidad de solapamientos detectados.

No existe un máximo de solapamientos definido por el sistema.

7.9 Estados del Turno clínico

Los estados disponibles son Agendado, Atendido, Cancelado y Ausente. Reprogramar no es un estado: consiste en cambiar fecha y/o hora del mismo Turno.

Los estados se actualizan manualmente y pueden corregirse posteriormente sin una matriz rígida de transiciones. Un Turno pasado que continúa Agendado puede reprogramarse; Cancelado o Ausente pueden corregirse a Atendido si la consulta efectivamente ocurrió; y un Cancelado puede volver a Agendado.

Pasar a Atendido crea la Atención asociada si todavía no existe. Salir de Atendido requiere que esa Atención pueda eliminarse sin perder información; si ya posee contenido clínico, Ingresos u otras dependencias, primero deben resolverse explícitamente.

Los Turnos Agendados cuya hora de inicio ya pasó no cambian automáticamente de estado. Se identifican claramente como pendientes de actualización y pueden localizarse mediante la agenda o un filtro específico, sin crear un quinto estado.

La cancelación y la ausencia no exigen motivo. No se generan ausencias automáticas por el paso del tiempo.

7.10 Turnos futuros y estado de la Persona

Un Turno clínico futuro en estado Agendado constituye actividad vigente. Una Persona Inactiva que recibe un Turno futuro Agendado pasa automáticamente a Activa y puede acceder al Portal para consultarlo.

Al llegar la hora de inicio, el Turno deja de considerarse futuro y ya no sostiene por sí solo el estado Activo, aunque permanezca Agendado hasta que el equipo lo actualice.

Si un Turno futuro pasa a Cancelado y no queda otra actividad vigente, el estado general se recalcula y la Persona puede volver a Inactiva.

7.11 Cancelación desde Portal

El Paciente puede cancelar un Turno clínico futuro desde el Portal hasta el momento de inicio. Una vez comenzado el horario, la gestión del estado queda en manos del equipo interno.

El Portal no permite crear, reprogramar ni seleccionar profesional para turnos clínicos.

7.12 Marcar un Turno como Atendido

Cuando un Turno se marca Atendido, el sistema crea automáticamente una única Atención asociada, heredando Persona, fecha/hora y profesional como valores iniciales.

En ese momento pueden registrarse opcionalmente Evolución, Evaluación clínica y asociación de la Atención a un Tratamiento. El Turno puede marcarse Atendido sin completar una Evolución.

Si se marca Atendido sin Evolución, se muestra una advertencia breve no bloqueante. No se crea un estado “Pendiente de evolución”, tarea ni cola permanente.

Si el Turno fue marcado Atendido por error y la Atención asociada está vacía y sin dependencias, la misma corrección puede eliminarla y cambiar el estado del Turno, incluso para reprogramarlo. Si la Atención ya posee contenido o relaciones, el cambio queda bloqueado hasta que sean corregidos o desvinculados explícitamente.

7.13 Atención clínica

La Atención representa una consulta que realmente ocurrió. Sus datos mínimos son Paciente, Fecha/Hora y Profesional.

Una Atención puede asociarse opcionalmente a un único Tratamiento. Puede tener como máximo una Evolución y una o varias Evaluaciones clínicas. También puede existir sin Tratamiento, sin Evolución y sin Evaluación.

Como referencia operativa de cobertura, la Atención se identifica como Particular u Obra social. No guarda una Obra social específica. Esta cobertura puede corregirse posteriormente y no genera cálculos ni liquidaciones automáticas.

La Fecha/Hora, el Profesional y la cobertura pueden corregirse por los roles habilitados para gestionar Atenciones. Los registros clínicos vinculados conservan sus propias autorías y no se reescriben automáticamente por corregir datos operativos de la Atención.

La Atención actualiza la referencia “Última atención” del Paciente. Turnos no atendidos, Estudios, Órdenes, Ingresos, Indicaciones para Sala o análisis de IA no actualizan esa fecha.

7.14 Atención sin Turno

Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo y Administrador general pueden registrar una Atención directamente desde la ficha de un Paciente sin crear un Turno retrospectivo.

La Fecha/Hora puede ser actual o pasada, nunca futura. El flujo propone la fecha/hora actual y puede modificarse cuando se está cargando historia.

Para Atenciones actuales se selecciona un profesional clínico activo. Al registrar o corregir historia pasada puede identificarse a un profesional actualmente Inactivo si fue quien efectivamente realizó la consulta.

El Administrativo puede registrar la existencia de la Atención y seleccionar el profesional correspondiente, pero no completar Evolución ni Evaluación clínica.

7.15 Eliminación de una Atención cargada por error

Una Atención puede eliminarse únicamente si no tiene registros clínicos o económicos asociados. Si posee Evolución, Evaluación, ingreso u otra relación que dependa de ella, primero se deben corregir o quitar esas vinculaciones.

Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo y Administrador general pueden eliminar una Atención vacía cargada por error mediante una confirmación simple.

Las Evoluciones y Evaluaciones clínicas sustantivas no se eliminan físicamente como mecanismo habitual.

7.16 Evolución clínica

La Evolución documenta de manera simple lo ocurrido durante una Atención. Cada Atención puede tener como máximo una Evolución.

Puede incluir Evolución clínica, Prácticas o maniobras realizadas e Indicaciones/próximos pasos. Para guardar una Evolución debe existir contenido en al menos uno de esos apartados; no se crean Evoluciones completamente vacías.

La fecha clínica de la Evolución es la fecha de la Atención a la que pertenece. La fecha efectiva de creación o modificación se conserva únicamente como trazabilidad.

No obliga a completar una Evaluación estructurada y no repite de forma artificial el objetivo o plan general del Tratamiento.

7.17 Corrección de Evoluciones

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general pueden corregir una Evolución cuando detectan un error. No existe aprobación, bloqueo por autor original, motivo obligatorio ni versionado completo.

La Evolución conserva autor y fecha clínica original, y registra último modificador y fecha de modificación cuando corresponde.

7.18 Tratamiento clínico

El Tratamiento clínico se utiliza únicamente cuando existe un proceso real de seguimiento. Una consulta aislada no obliga a crear un Tratamiento.

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general pueden crear, modificar, finalizar y reabrir Tratamientos. Una Persona puede tener varios Tratamientos En curso simultáneamente cuando corresponden a problemas o zonas diferentes.

Las Atenciones pueden asociarse opcionalmente a un único Tratamiento. Los Turnos clínicos no se vinculan a Tratamientos.

7.19 Datos mínimos del Tratamiento

Cada Tratamiento registra Motivo de consulta, Zona corporal o lesión, Fecha de inicio y Profesional responsable.

La Fecha de inicio puede ser hoy o una fecha pasada, nunca futura.

Puede incluir además un Objetivo breve, un Plan de prácticas/intervención y una Etapa actual opcional. Las Indicaciones destinadas a Sala se mantienen como registros separados.

7.20 Profesional responsable

Cada Tratamiento En curso tiene un Profesional responsable. Esto organiza el seguimiento, pero no restringe la intervención de otros Kinesiólogos u Osteópatas.

Cuando un profesional clínico crea un Tratamiento, el sistema propone como responsable al creador. Puede seleccionar otro profesional y el responsable puede cambiarse posteriormente sin modificar la autoría de intervenciones previas.

Cambiar el responsable no modifica Turnos clínicos, porque cada Turno conserva su propio profesional y no se vincula al Tratamiento.

Si el Administrador general crea un Tratamiento sin poseer rol clínico, debe seleccionar explícitamente un Kinesiólogo u Osteópata responsable.

7.21 Estados del Tratamiento

El Tratamiento utiliza únicamente los estados En curso y Finalizado.

Al finalizar se registra una Fecha de finalización. El sistema propone la fecha actual y permite modificarla por una fecha pasada, siempre que no sea anterior a la Fecha de inicio ni a la última Atención asociada al Tratamiento. No se permite una Fecha de finalización futura.

Puede indicarse de forma opcional un motivo: Alta, Interrupción, Derivación u Otro, y una Conclusión opcional.

No se agregan estados intermedios como Pausado, Abandonado o En espera.

7.22 Reapertura

Un Tratamiento Finalizado puede reabrirse y volver a En curso tantas veces como la situación real lo requiera. Reabrir es también el mecanismo para corregir una finalización realizada por error.

La reapertura no solicita una Fecha de reapertura independiente ni administra períodos. El sistema conserva como trazabilidad relevante cuándo se realizó la acción y mantiene la historia del Tratamiento.

Al reabrir, si el Profesional responsable anterior continúa Activo y conserva un rol clínico, se mantiene. Si está Inactivo o ya no posee rol Kinesiólogo u Osteópata, debe elegirse un profesional clínico activo antes de completar la reapertura.

Si la Persona estaba Inactiva y no existe otra actividad, la reapertura vuelve a convertirla en Activa. Las Indicaciones para Sala no se modifican automáticamente por la reapertura.

7.23 Tratamientos sin Atención reciente

El sistema no cierra Tratamientos automáticamente por el paso del tiempo. Permite identificar Tratamientos En curso que llevan tiempo sin una Atención.

El listado de Pacientes ofrece filtros de 30, 60 y 90 o más días sin Atención reciente. El Tratamiento ingresa en cada filtro al cumplirse esa cantidad de días completos.

Cuando ya tuvo Atenciones, el cálculo se realiza desde la última Atención. Si nunca tuvo ninguna, se cuenta desde la Fecha de inicio del Tratamiento.

El Inicio de Clínica utiliza 30 días como umbral inicial y conduce al listado filtrado. El equipo decide caso por caso si corresponde continuar o finalizar el Tratamiento; no existe cierre masivo ni automático.

7.24 Finalización de Tratamiento con indicaciones para Sala activas

Si un Tratamiento se finaliza mientras existen indicaciones para Sala activas relacionadas, el sistema no las cierra automáticamente. Muestra una advertencia para que el profesional las revise, pero permite finalizar el Tratamiento.

Esta separación existe porque una restricción de entrenamiento puede seguir siendo válida por un tiempo aun cuando el Tratamiento principal haya finalizado.

> **Ejemplo de advertencia:** “Este tratamiento tiene indicaciones activas para Sala. Revisalas para confirmar si deben seguir vigentes.”

7.25 Estudios y archivos

La Historia Clínica posee una sección única de Estudios y archivos. Cada registro requiere Fecha y Tipo; Descripción, archivo y asociación a un Tratamiento son opcionales.

Tipo es un texto breve y libre, por ejemplo Resonancia, Radiografía, Ecografía o Informe médico. No existe un catálogo de tipos.

Cada registro admite como máximo un archivo en imagen o PDF. Puede existir sin archivo cuando se necesita dejar únicamente una referencia descriptiva del Estudio.

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general pueden cargar y corregir estos registros. Un archivo puede quitarse o reemplazarse si fue cargado por error, sin conservar versiones. La asociación a Tratamiento puede agregarse, cambiarse o quitarse sin afectar el Estudio.

7.26 Indicaciones clínicas para Sala

Una Indicación para Sala es un registro clínico creado para comunicar al área de entrenamiento una condición concreta y accionable. Puede existir con o sin Tratamiento asociado.

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general pueden crear o modificar Indicaciones. La Condición de entrenamiento es obligatoria y utiliza Sin restricciones, Con restricciones o No entrenar. Zona afectada es opcional. Las Instrucciones son obligatorias únicamente para Con restricciones.

La Indicación rige desde su creación y permanece activa hasta que se cierra. No utiliza una Fecha de inicio adicional ni vencimiento programado.

La asociación con Tratamiento es contextual: puede agregarse, cambiarse o quitarse sin afectar la vigencia de la Indicación. Finalizar o reabrir el Tratamiento tampoco modifica automáticamente sus Indicaciones.

7.27 Cierre de indicaciones

Cualquier usuario interno puede cerrar una Indicación para Sala con una advertencia explícita. La acción no permite editar contenido clínico y conserva quién realizó el cierre y cuándo.

Una Indicación cerrada no se reabre. Si vuelve a ser necesaria, se crea una nueva.

Al dar de baja a la Persona de Sala, todas las Indicaciones activas destinadas a Sala se cierran automáticamente y quedan históricas.

7.28 Evaluación clínica estructurada

La Evaluación clínica documenta de manera estructurada tests y hallazgos de una consulta. Siempre pertenece a una Atención y una misma Atención puede contener una o varias Evaluaciones clínicas.

Cada Evaluación puede asociarse opcionalmente a un Tratamiento a través de su Atención. Puede iniciarse desde una Atención existente o desde la ficha del Paciente; si todavía no existe una Atención para esa consulta, el flujo crea o asocia la Atención dentro del mismo proceso.

La estructura se conserva porque permite comparar mediciones objetivas y sirve como base explícita para el análisis con Inteligencia Artificial.

7.29 Estructura de Evaluación clínica

Cada Evaluación identifica una Zona corporal o Tipo mediante texto breve libre, sin catálogo específico.

Puede utilizar como máximo un Protocolo opcional como guía. El profesional puede omitir Tests propuestos, agregar otros existentes o crear un Test nuevo durante la misma carga. Los Tests creados en ese contexto quedan disponibles en el catálogo reutilizable.

Los formatos de respuesta de un Test pueden ser Positivo/Negativo/Inconcluso/No realizado, Valor numérico, Escala, Opciones o Texto breve. Los Tests de tipo Opciones definen previamente sus opciones. Los Tests numéricos pueden definir una Unidad que se aplica de forma consistente a sus resultados.

Un mismo Test puede aparecer más de una vez dentro de la Evaluación, por ejemplo para distintos lados corporales. Cada resultado puede indicar opcionalmente el lado corporal y una Observación.

Para guardar una Evaluación debe existir al menos un Resultado de Test. La Conclusión general es opcional; si solo se necesita documentar narrativa clínica sin Tests, corresponde utilizar la Evolución.

7.30 Protocolos clínicos

Los Protocolos son plantillas reutilizables que organizan secciones y Tests habituales para una zona o tipo de Evaluación. Una Evaluación utiliza como máximo un Protocolo, que funciona como punto de partida y no como estructura rígida.

Los Tests clínicos pueden reutilizarse en distintos Protocolos y Evaluaciones. Los Protocolos pueden incluir orientaciones simples, pero no obligan a ejecutar otros Tests ni determinan automáticamente diagnósticos.

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general administran Protocolos y Tests clínicos. Los Protocolos utilizan estado Activo/Inactivo. Los Tests clínicos no utilizan ese estado: pueden retirarse de nuevas selecciones manteniendo intacta la historia.

7.31 Preservación histórica de Evaluaciones

Una Evaluación histórica conserva la definición del Protocolo y de los Tests con la que fue registrada. Cambios posteriores del catálogo no alteran el significado de Resultados ya documentados.

Esta preservación es una excepción deliberada a la regla general de los catálogos y existe por integridad clínica y por el uso de la Evaluación como insumo de análisis con IA.

7.32 Corrección de Evaluaciones

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general pueden corregir una Evaluación cuando existe un error. La corrección puede modificar Resultados, agregar o quitar Tests, ajustar lado corporal, Observaciones o Conclusión.

No se crea una versión independiente visible para el usuario. Se conserva autor/fecha y último modificador/fecha según la trazabilidad clínica definida.

7.33 Evaluación corregida después de un análisis con IA

Si una Evaluación que ya fue analizada con IA se corrige -incluyendo cambios de Resultados, agregado o eliminación de Tests-, los análisis guardados previamente no se modifican ni se recalculan automáticamente.

Si el profesional necesita un resultado basado en los datos corregidos, ejecuta un nuevo análisis. De esta forma la IA nunca altera silenciosamente una conclusión guardada.

7.34 Tests y mediciones objetivas

Los Tests clínicos pueden registrar valores objetivos numéricos cuando corresponde. La Unidad, cuando aplica, se define en el propio Test y no se cambia resultado por resultado.

El lado corporal se registra opcionalmente en cada Resultado únicamente cuando aporta significado.

Cuando existen mediciones repetidas y comparables, el sistema puede mostrar su evolución en una tabla cronológica o un gráfico simple. La comparación utiliza por defecto el Tratamiento actual cuando existe contexto aplicable y puede ampliarse a toda la historia de la Persona.

7.35 Dispositivo o método de medición

Cuando un valor objetivo fue obtenido mediante un dispositivo o método concreto, el Test puede referenciar opcionalmente un catálogo mínimo de Dispositivos/Métodos.

El catálogo contiene Nombre obligatorio y Descripción opcional. No utiliza estado Activo/Inactivo: un elemento que deja de utilizarse se retira de nuevas selecciones y las Evaluaciones históricas continúan identificándolo.

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general pueden administrarlo. No se registran número de serie, calibraciones, mantenimiento u otros datos técnicos del equipo.

7.36 Análisis con Inteligencia Artificial

La IA funciona como una herramienta de apoyo profesional sobre una Evaluación clínica estructurada. Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general pueden ejecutar el análisis únicamente mediante la acción explícita “Analizar evaluación con Inteligencia Artificial”.

No se ejecuta automáticamente al guardar una Evaluación, no navega Internet y no actualiza el Tratamiento, el diagnóstico, las indicaciones ni ninguna otra información clínica por sí sola.

7.37 Fuentes permitidas para IA

El análisis utiliza exclusivamente fuentes activas de la Biblioteca Clínica aprobada por Athleta. La selección se realiza automáticamente según zona, Protocolo y fuentes generales aplicables.

Si no existen fuentes aplicables, el sistema no genera un análisis como si tuviera respaldo suficiente. Debe informar que no dispone de material aprobado adecuado para esa Evaluación.

7.38 Contenido del análisis de IA

El resultado presenta hipótesis priorizadas, hallazgos que apoyan o contradicen cada hipótesis, tests o información faltante que podrían ser útiles, posibles tratamientos o maniobras organizados por etapas y las fuentes utilizadas.

La compatibilidad se expresa de manera cualitativa como Alta, Media o Baja. No se utilizan porcentajes de certeza diagnóstica.

La respuesta se presenta claramente como apoyo para el profesional y no como sustituto de su conclusión clínica.

7.39 Guardar o descartar un análisis

El resultado inicial de la IA es preliminar. El profesional puede Guardar o Descartar.

Solo los análisis guardados pasan a formar parte de la Historia Clínica. Un análisis guardado es inmutable: no se edita. Si se necesita revisar el caso, se ejecuta y guarda un nuevo análisis.

No existen estados Aceptado, Rechazado, Aprobado ni flujos de validación adicionales. La conclusión profesional y el plan terapéutico se documentan por separado.

7.40 Biblioteca Clínica

La Biblioteca Clínica reúne las fuentes aprobadas que pueden ser consultadas por los profesionales y utilizadas por la IA.

Admite textos, PDF y videos. Cada recurso registra Título, Zona o categoría, Tipo, archivo o contenido y Descripción opcional. Utiliza estado Activo/Inactivo.

Kinesiólogo, Osteópata y Administrador general pueden administrar la Biblioteca sin circuito de aprobación adicional.

7.41 Selección de fuentes para IA

No se requiere que el profesional seleccione manualmente las fuentes antes de cada análisis. El sistema utiliza automáticamente las fuentes activas más aplicables según el contexto y muestra cuáles utilizó en el resultado.

La IA no consulta fuentes web abiertas.

7.42 Obras sociales

Clínica utiliza un catálogo simple de Obras sociales identificado por Nombre. Administrativo y Administrador general administran el catálogo; Kinesiólogo y Osteópata pueden seleccionar las Obras sociales disponibles al operar información clínica o económica.

La ficha de Persona conserva únicamente la Obra social y número de afiliado actuales, sin historial específico de cambios. Los registros históricos que referencian una Obra social conservan naturalmente ese contexto.

Las Obras sociales no utilizan estado Activo/Inactivo. Una Obra social retirada deja de estar disponible para nuevas selecciones, pero continúa mostrándose en Personas y registros que ya la referenciaban hasta que esos datos sean modificados.

7.43 Orden de obra social

La Orden de obra social es un registro administrativo asociado a un Paciente. No implementa liquidación, autorización automática ni control de consumo de sesiones.

Sus campos son Paciente, Obra social, Fecha de emisión, Referencia opcional, Cantidad autorizada opcional, Fecha de vencimiento opcional, Observación opcional y un archivo opcional en imagen o PDF.

La Fecha de emisión puede ser hoy o una fecha anterior, nunca futura. Cuando se informa Cantidad autorizada debe ser un entero positivo y su valor es informativo.

Una Persona puede tener varias Órdenes de la misma Obra social simultáneamente. No existe un concepto de única Orden vigente ni prioridad automática entre ellas.

7.44 Vencimiento de una Orden

La Fecha de vencimiento es opcional e informativa. Si ya pasó, la Orden continúa disponible en la historia y puede mostrarse como vencida, pero no bloquea Atenciones, Turnos, Ingresos ni otros procesos.

No se generan tareas, renovaciones automáticas ni estados adicionales a partir del vencimiento.

7.45 Permisos sobre Órdenes

Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo y Administrador general pueden crear y modificar Órdenes de obra social. Profesor no accede a este circuito salvo que posea otro rol habilitado.

7.46 Eliminación de una Orden cargada por error

Una Orden incorrecta puede eliminarse definitivamente mediante confirmación simple. No existe estado Anulada ni motivo obligatorio.

Si un Ingreso clínico está vinculado a esa Orden, primero debe corregirse el Ingreso para quitar o cambiar la referencia. Luego la Orden puede eliminarse.

7.47 Ingreso clínico

El Ingreso clínico registra dinero efectivamente recibido por Athleta relacionado con un Paciente. No utiliza tarifario ni calcula automáticamente valores de consulta.

Cada Ingreso registra Paciente, Fecha de cobro, Importe, Medio de pago, Pagador y Observación opcional. La Fecha de cobro propone la fecha actual, puede ser anterior y nunca puede ser futura.

El Importe debe ser mayor a cero. No se registran Ingresos negativos ni existe lógica de devolución o reversión dentro del alcance actual.

La Fecha de cobro representa el día en que Athleta recibió el dinero y puede diferir de la fecha de la Atención.

7.48 Pagador

El Pagador puede ser Paciente u Obra social. Si se selecciona Obra social, se identifica cuál.

Puede elegirse cualquier Obra social actualmente disponible en el catálogo, aunque no coincida con la Obra social actual de la Persona. Esta última puede proponerse por comodidad, pero nunca funciona como restricción.

El Pagador puede corregirse posteriormente entre Paciente y Obra social como una modificación normal. Esa corrección no modifica automáticamente Atenciones, Órdenes u otros registros relacionados.

La identidad del Pagador es independiente del Medio de pago. Una Obra social responde a quién entrega el dinero a Athleta, no a cómo se recibió.

7.49 Asociación opcional a Orden y Atención

El Ingreso puede asociarse opcionalmente a una Orden de obra social del Paciente y/o a una Atención del Paciente. Estas relaciones aportan contexto, pero no son obligatorias.

Se permiten múltiples Ingresos asociados a la misma Orden o Atención. El sistema no implementa conciliación, saldos de Orden, copagos, coseguros ni reglas de reparto.

7.50 Registro manual del importe

El Importe se carga manualmente y debe ser mayor a cero. No existen conceptos clínicos tarifados, lista de precios de prestaciones ni cálculo automático según Obra social o profesional.

7.51 Permisos sobre Ingresos clínicos

Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo y Administrador general pueden registrar, corregir y eliminar Ingresos clínicos. La eliminación es definitiva y requiere confirmación simple.

Los profesionales clínicos pueden consultar el historial clínico-económico necesario para trabajar con estos ingresos dentro de Clínica. Administrativo y Administrador general pueden además consultarlos dentro del listado unificado de Ingresos.

7.52 Casos que no representan un Ingreso de Athleta

No se registra como Ingreso un reintegro que una Obra social paga directamente al Paciente después de que el Paciente ya abonó a Athleta. Athleta Manager registra únicamente dinero que efectivamente ingresa a Athleta.

7.53 Ausencia de facturación compleja

Clínica no implementa liquidaciones por Obra social, consumo de sesiones autorizadas, cuentas corrientes de financiadores, facturación electrónica, copagos estructurados, conciliaciones automáticas ni lógica de devoluciones/reversiones.

Las Órdenes e Ingresos se mantienen deliberadamente simples e independientes.

8. Finanzas

8.1 Enfoque financiero

Finanzas brinda una visión simple de movimientos económicos operativos de Athleta. No pretende reemplazar un sistema contable ni incorporar presupuestos, cuentas bancarias, proveedores, facturación o planificación financiera avanzada.

Los Ingresos de Sala y Clínica se integran en una única visión para quienes tienen permisos financieros transversales, manteniendo identificado el origen de cada movimiento.

8.2 Ingresos unificados

El listado unificado de Ingresos reúne Pagos de Sala e Ingresos clínicos. Permite filtrar por Área, Fecha, Persona y Medio de pago.

Cada movimiento mantiene su naturaleza original. Un Pago de Sala responde a un Mes/Año que determina qué cuota queda pagada; un Ingreso clínico responde a un Paciente y una Fecha de cobro. La unificación sirve para consulta y totales.

Administrativo y Administrador general pueden consultar esta visión transversal.

Para filtros por fecha, totales, dashboard, exportaciones y referencia en USD se utiliza criterio de caja real: Fecha real de cobro en Pagos de Sala, Fecha de cobro en Ingresos clínicos y Fecha en Gastos. El Mes/Año del Pago puede incluso ser futuro y se utiliza únicamente para determinar el estado mensual del Alumno.

8.3 Eliminación de movimientos económicos

Los movimientos económicos cargados por error pueden corregirse o eliminarse directamente cuando el rol posee permiso para operar ese tipo de movimiento. No se utiliza estado Anulado ni un circuito de reversión.

La eliminación requiere una confirmación simple que identifique claramente el movimiento. No se solicita motivo obligatorio ni doble confirmación.

Al eliminarse, el movimiento deja de intervenir en listados, totales, estados de pago y dashboard. Athleta Manager no incorpora lógica general de devoluciones económicas.

8.4 Gastos

Todo usuario interno puede registrar un Gasto para facilitar la carga en el momento en que se produce. Registrar un Gasto no implica acceso al historial económico general.

Cada Gasto incluye Fecha, Importe, Categoría, Medio de pago, Área y Descripción opcional. El Área puede ser Sala, Clínica o General. La Fecha representa un egreso ocurrido y debe ser hoy o una fecha anterior, nunca futura.

Administrativo y Administrador general pueden consultar el listado completo de Gastos, aplicar filtros, corregir y eliminar movimientos. Profesor, Kinesiólogo y Osteópata pueden registrar un Gasto y recibir confirmación, pero no acceden al historial general salvo que además posean un rol habilitado.

8.5 Categorías de gastos

El catálogo de Categorías de gasto es simple y administrado por Administrativo y Administrador general.

No utiliza estado Activo/Inactivo. Una Categoría retirada deja de estar disponible para nuevos Gastos y los movimientos históricos continúan identificándola.

8.6 Medios de pago compartidos

Sala, Clínica y Gastos utilizan un catálogo común de Medios de pago administrado por Administrativo y Administrador general.

No utiliza estado Activo/Inactivo. Retirar un Medio de pago impide seleccionarlo en nuevos movimientos, pero los registros históricos continúan mostrando la referencia utilizada.

8.7 Dashboard financiero del Administrador general

El Administrador general dispone de una vista financiera resumida orientada a entender el período seleccionado. Muestra Total de ingresos, Total de gastos y Neto.

Los Ingresos se separan en Sala y Clínica. Los Gastos se separan en Sala, Clínica y General.

Los accesos rápidos de período son Mes actual, Mes anterior y Año actual, además de un Rango personalizado para cualquier otra consulta.

Puede filtrar por Área, Tipo de movimiento y Medio de pago cuando aporte valor. No incluye presupuesto, proyecciones, cuentas, conciliaciones bancarias, ranking de profesionales ni indicadores financieros sofisticados.

8.8 Visión económica del Administrativo

El Administrativo puede trabajar con listados, filtros, historiales y totales operativos de Ingresos y Gastos. No dispone de la vista global de Neto, tendencias o lectura ejecutiva reservada al Administrador general.

8.9 Moneda operativa y referencia en USD

Los movimientos se registran operativamente en pesos argentinos. El Administrador general puede consultar el dashboard expresado en ARS o como referencia en USD.

Para la referencia en USD se utiliza una única cotización mensual definida como 1 USD = X ARS. Administrativo y Administrador general pueden crear y corregir esa cotización en cualquier momento; no se conserva historial de valores anteriores.

Cuando una cotización mensual se corrige, las consultas posteriores utilizan el nuevo valor. Para períodos de varios meses, cada movimiento se convierte con la cotización correspondiente a su mes.

Si falta la cotización de uno o más meses incluidos, la consulta en ARS continúa disponible, pero no se calcula un total USD parcial. El sistema informa qué meses necesitan cotización.

8.10 Exportación

Administrativo y Administrador general pueden exportar a Excel los listados filtrados de Ingresos y Gastos. La exportación respeta los filtros aplicados y utiliza un conjunto fijo de columnas funcionales; no existe selector o diseñador de columnas.

Para Gastos se exportan Fecha, Importe, Categoría, Medio de pago, Área, Descripción y Usuario que registró.

Para Ingresos se exportan Fecha de cobro, Área, Tipo de ingreso, Persona, Importe, Medio de pago y Usuario que registró, junto con los datos propios que aportan sentido al movimiento: Mes/Año y Motivo de ajuste para Sala; Pagador, Obra social y Observación para Clínica.

No existe un generador de reportes, exportación masiva genérica de Personas ni reportes PDF configurables.

8.11 Pagos online

Athleta Manager no procesa dinero online. No incluye pasarela de pagos, tarjetas, débitos automáticos, links de cobro ni transferencias iniciadas desde el sistema.

Los movimientos económicos se registran después de que el dinero fue recibido por un medio externo.

9. Inicio y tableros operativos

9.1 Inicio unificado

La pantalla Inicio es única y adapta su contenido a los roles del usuario. No existe un dashboard separado que obligue a cambiar entre Sala y Clínica.

Profesor ve principalmente Sala; Kinesiólogo u Osteópata, Clínica; Administrativo ve ambos bloques operativos; Administrador general puede ver todos los bloques relevantes.

Cuando un usuario posee capacidades de Sala y Clínica, ambos bloques tienen la misma jerarquía funcional y un orden estable: Sala primero y Clínica después. En escritorio pueden distribuirse aprovechando el ancho disponible, pero el orden lógico se mantiene y no se personaliza por usuario.

9.2 Selector temporal

El Inicio operativo permite alternar entre Hoy y Mañana para las tarjetas relacionadas con agenda y actividad diaria. La vista semanal se accede desde la Agenda Clínica mediante la acción “Ver semana”, sin convertir Semana en un tercer modo global del Inicio.

El estado de Pago pendiente del mes actual es independiente de ese selector porque responde a una regla mensual.

9.3 Bloque de Sala

El bloque de Sala presenta cantidad de Alumnos esperados, Asistencias registradas, Cancelados/Ausentes, próximos horarios, Alumnos con Pago pendiente del mes y Alumnos sin Rutina activa.

Alumnos esperados cuenta únicamente Turnos fijos y reservas puntuales. Una incorporación espontánea registrada como Asistió suma a Asistencias registradas, pero no modifica la planificación original.

Las tarjetas son accionables y abren el listado o agenda ya filtrados para mostrar los registros que componen cada número.

9.4 Bloque de Clínica

El bloque de Clínica presenta Turnos del día, Turnos Atendidos, Cancelados/Ausentes, Próximos Turnos y Tratamientos sin Atención reciente.

Próximos Turnos muestra hasta 5 Turnos Agendados de la fecha seleccionada, ordenados por hora. En Hoy muestra únicamente los que todavía no comenzaron; en Mañana muestra los primeros Agendados del día siguiente. Desde este bloque se puede abrir la agenda completa y acceder a “Ver semana”.

Los Turnos Agendados cuyo horario ya pasó quedan fuera de Próximos Turnos y deben poder localizarse fácilmente como pendientes de actualización mediante la agenda o un acceso filtrado.

La tarjeta Atendidos hoy cuenta Atenciones clínicas efectivamente registradas, incluyendo Atenciones directas sin Turno. Tratamientos sin Atención reciente utiliza 30 días como umbral inicial y conduce al listado filtrado.

9.5 Sin panel de Atenciones sin Evolución

El sistema no crea un indicador especial de Atenciones sin Evolución. Marcar un Turno Atendido sin Evolución es una posibilidad válida que se advierte en el momento, sin generar una cola permanente de pendientes.

9.6 Sin personalización de widgets

Los usuarios no personalizan, reordenan ni esconden tarjetas del Inicio. La priorización se define por rol para que el sistema sea consistente y fácil de aprender.

Los elementos accionables se presentan antes que métricas meramente informativas.

10. Portal Athleta

10.1 Propósito

El Portal Athleta es la experiencia de autoservicio para Personas Activas. Debe ser considerablemente más simple que el sistema interno y mostrar únicamente información relevante para el Alumno o Paciente.

No replica la administración interna ni expone herramientas clínicas o financieras que no correspondan.

10.2 Acceso

El acceso se realiza con DNI y PIN numérico de cuatro dígitos.

Toda Persona recibe un PIN inicial aleatorio al ser creada. El PIN no vence por tiempo, se muestra una sola vez al usuario interno y debe cambiarse en el primer acceso.

Una Persona Inactiva no puede acceder al Portal aunque posea un PIN válido.

La inactivación bloquea el acceso, pero no elimina el DNI ni el PIN. Si la Persona vuelve a quedar Activa, puede utilizar las mismas credenciales salvo que el PIN haya sido restablecido. La reactivación no recupera automáticamente turnos, reservas u otras relaciones que hubieran finalizado al inactivarse.

10.3 Manejo de errores de acceso

Los errores de autenticación utilizan un mensaje genérico que no revela si el DNI existe, si la Persona está Inactiva o si el PIN es incorrecto. Esto protege la privacidad sin agregar complejidad al usuario.

El mensaje puede orientar a contactar a Athleta mediante el número de WhatsApp configurado para resolver acceso o consultas. La pantalla de acceso también puede ofrecer un acceso breve para quien quiera comunicarse con Athleta o consultar cómo sumarse, utilizando ese mismo canal. El número es una configuración general administrada por Administrativo y Administrador general.

10.4 Contenido adaptado a la Persona

El Inicio del Portal se construye según las relaciones actuales y prioriza lo que la Persona necesita consultar o hacer en ese momento: próximos turnos o reservas y, cuando corresponde, acceso a su rutina, estado de pago del mes y evaluaciones físicas. Una Persona que solo utiliza Clínica no ve módulos vacíos de Sala. Una Persona que solo participa de Sala no ve secciones clínicas sin contenido.

Si utiliza ambas áreas, el Portal reúne los próximos compromisos y accesos relevantes en una sola experiencia, sin selector de área obligatorio.

10.5 Información disponible para Sala

Cuando la Persona participa de Sala, el Portal muestra próximos Turnos y reservas, gestión de Turnos fijos, reserva puntual, Rutina activa, estado de pago del mes actual y Resultados de Evaluaciones físicas.

Los compromisos futuros Cancelados permanecen visibles e identificados como tales hasta que pasa su fecha/hora. Después dejan de mostrarse; no existe historial de asistencias ni de cancelaciones pasadas.

No muestra historial de pagos, importes, deuda acumulada ni ingresos económicos.

10.6 Gestión de turnos fijos desde Portal

El Alumno puede crear, cambiar o finalizar sus propios Turnos fijos sin aprobación interna, siempre sujeto a los horarios disponibles y a la capacidad de Sala.

Al elegir un horario, el sistema propone como Fecha de inicio su próxima ocurrencia y deja la Fecha de finalización como “Sin fecha de finalización”. El Alumno puede modificar ambas fechas, siempre hacia adelante.

Cambiar un Turno fijo es una única acción para el Alumno y afecta únicamente hacia adelante desde la nueva Fecha de inicio; nunca reescribe ocurrencias pasadas.

También puede cancelar una ocurrencia futura concreta hasta el momento de inicio sin alterar la recurrencia de las semanas siguientes. La interfaz no impone máximo de Turnos fijos ni valida la frecuencia comercial del Plan.

10.7 Reserva puntual desde Portal

El Alumno puede reservar un horario puntual dentro de los próximos 30 días. Solo puede hacerlo si participa de Sala, está Activo y existe capacidad.

Puede reservar más de un horario en una misma fecha siempre que sean horarios distintos y haya lugar. No existe un máximo diario ni control de frecuencia según Plan.

La disponibilidad se expresa como Hay lugar o Sin lugar. Si una reserva preexistente se conservó en un horario que luego quedó sobreocupado y el Alumno la cancela, solo puede volver a reservar si en ese momento existe capacidad disponible.

La reserva puede cancelarse hasta el inicio del horario. Después del inicio, el estado se gestiona internamente.

10.8 Rutina en Portal

El Portal muestra únicamente la rutina activa, completa y en modo lectura. El Alumno puede recorrer sus días y ejercicios, pero no registrar ejecución, carga real, comentarios ni resultados de la sesión.

10.9 Evaluaciones físicas en Portal

El Alumno puede consultar el historial de Resultados de Evaluaciones físicas. La presentación es simple y cronológica por Test, mostrando el Resultado tal como fue registrado por el Profesor, sin dashboards ni gráficos avanzados.

10.10 Estado de pago

El Portal muestra únicamente “Pago registrado” o “Pago pendiente” para el mes actual. No muestra monto ni historial.

10.11 Información clínica en Portal

El Portal muestra Turnos clínicos futuros Agendados y también Turnos futuros Cancelados. Los Cancelados permanecen visibles, claramente identificados y sin acciones, hasta que pasa su fecha/hora.

El Paciente puede cancelar un Turno Agendado hasta su hora de inicio. No puede autoagendar Clínica, seleccionar profesional ni reprogramar Turnos.

Atendido y Ausente no se muestran como compromisos futuros. El Portal tampoco permite consultar Historia Clínica, Evoluciones, Evaluaciones clínicas, diagnósticos, Tratamientos, Estudios, Órdenes, análisis de IA, pagos ni Ingresos clínicos.

10.12 Mis datos

La sección Mis datos permite consultar la información general disponible para la Persona. Es de solo lectura; las correcciones de datos generales se realizan con el equipo de Athleta.

10.13 Cambio y restablecimiento de PIN

La Persona puede cambiar su PIN desde el Portal. El nuevo valor siempre es numérico de cuatro dígitos.

Si lo olvida, cualquier usuario interno puede restablecerlo desde la ficha. El sistema genera un PIN temporal aleatorio, lo muestra una sola vez y exige cambio en el siguiente acceso.

10.14 Ausencia de notificaciones automáticas

El Portal no depende de recordatorios por WhatsApp, email o SMS enviados automáticamente. Athleta puede continuar utilizando sus canales habituales de comunicación de forma manual.

10.15 Presencia de marca

El Portal utiliza la identidad visual de Athleta como marca principal. La presencia de Broco Solutions se mantiene de forma discreta y profesional, por ejemplo mediante “Desarrollado por Broco Solutions”, logo y enlace institucional en login o pie de página.

11. Navegación, búsqueda y organización de la información

11.1 Navegación interna unificada

La aplicación interna posee una única navegación organizada conceptualmente por Inicio, Sala, Clínica, Finanzas y Equipo/Configuración. Las secciones aparecen según los permisos del usuario.

Un usuario con más de un rol no cambia de entorno. La navegación incorpora todas las áreas que puede utilizar.

11.2 Interfaz consciente de permisos

La interfaz muestra principalmente lo que el usuario puede usar. No se llena la pantalla con pestañas bloqueadas y botones deshabilitados para funciones que nunca podrá ejecutar.

Ejemplo: Un Administrativo puede ver turnos, órdenes e ingresos clínicos, pero no debe ver una pestaña completa de Evoluciones con todos sus controles deshabilitados.

11.3 Consulta versus edición

Cuando un rol puede consultar información pero no modificarla, la pantalla se presenta naturalmente en modo lectura. No se agregan controles grises o formularios bloqueados sin necesidad.

11.4 Preservación del contexto

Al abrir un detalle desde un listado y regresar, el sistema conserva filtros, búsqueda, orden, página y posición de trabajo cuando sea razonable.

Este criterio es especialmente importante en Alumnos, Pacientes, agendas, Tratamientos, Ingresos y Gastos.

11.5 Tablas y listados

Las tablas se utilizan cuando permiten comparar, filtrar, ordenar o ejecutar acciones sobre conjuntos de registros. La fila puede actuar como acceso natural al detalle, evitando repetir un botón “Ver” en cada línea cuando no aporta valor.

Las acciones frecuentes pueden permanecer visibles; las excepcionales se agrupan en acciones secundarias.

Las casillas de selección solo aparecen en listados que tienen acciones masivas reales, como Alumnos.

11.6 Paginación y scroll

Los listados de gestión que pueden crecer indefinidamente, como Alumnos, Pacientes, Ingresos, Gastos o Equipo, utilizan paginación o una navegación equivalente que permita regresar al mismo punto de trabajo.

Los contenidos cronológicos dentro de una ficha, como Atenciones o Evoluciones, pueden utilizar scroll porque su lectura es secuencial.

No existe una obligación de usar el mismo patrón para todos los tipos de información.

11.7 Filtros

Cada módulo ofrece filtros realmente útiles para su tarea. Los filtros principales permanecen visibles y los secundarios pueden agruparse para evitar pantallas sobrecargadas.

Los filtros activos deben ser evidentes y existir una acción sencilla para Limpiar filtros.

Cuando el usuario llega desde una tarjeta del Inicio, el filtro que originó la navegación queda visible para explicar por qué se muestran esos resultados.

12. Criterios de UX/UI y comportamiento de la interfaz

12.1 Identidad visual

La identidad de Athleta domina visualmente la aplicación. Se utilizan su logo, colores y referencias reconocibles como base, siempre que mantengan contraste y legibilidad adecuados.

La interfaz debe ser limpia, sobria y operativa. No se utilizan fotografías decorativas, fondos recargados o elementos de branding que compitan con el trabajo diario.

Los colores de Broco no dominan la interfaz.

12.2 Co-branding de Broco Solutions

La firma “Desarrollado por Broco Solutions”, acompañada por el logo cuando el espacio lo permita y un enlace al sitio institucional, debe estar presente de forma discreta.

Puede tener algo más de visibilidad en las pantallas de acceso y mantenerse secundaria dentro de la aplicación, por ejemplo en pie de navegación o footer.

No se muestran banners, promociones ni llamados comerciales dentro de los flujos operativos.

12.3 Diseño responsive

Athleta Manager es una única aplicación web responsive. No existe una aplicación móvil funcionalmente distinta.

Las tareas frecuentes deben ser cómodas en celular: consultar agenda, registrar asistencia, buscar Personas, registrar una Atención, consultar una rutina, registrar un pago o cargar un gasto.

Responsive no significa reducir el escritorio a una pantalla pequeña. En móvil la información se reorganiza para evitar zoom, scroll horizontal innecesario y controles diminutos.

12.4 Acciones táctiles

Ninguna acción importante puede depender únicamente de hover o precisión de mouse. Los controles frecuentes deben ser localizables y utilizables con el dedo.

Las tablas de escritorio pueden transformarse en filas o tarjetas legibles en móvil, priorizando los datos esenciales y dejando el resto para el detalle.

12.5 Formularios simples

Cada formulario solicita únicamente la información necesaria para la tarea actual. Los campos secundarios u opcionales se presentan sin competir con los datos obligatorios.

Los valores predecibles se proponen cuando ayudan: fecha actual, profesional autenticado si es válido, precio actual del Plan o datos heredados del Turno al crear una Atención.

Los valores propuestos deben ser visibles y modificables cuando la regla lo permite. No se oculta lógica importante detrás de automatizaciones silenciosas.

12.6 Guardado explícito

Las altas y modificaciones de datos reales utilizan acciones explícitas como Guardar, Registrar, Actualizar o Finalizar.

No se utiliza autosave general mientras el usuario escribe, especialmente en Historia Clínica, rutinas, pagos o configuración.

Filtros, búsquedas, pestañas y navegación sí reaccionan de manera inmediata porque no modifican datos persistentes.

12.7 Cambios sin guardar

En formularios significativos, si existen cambios pendientes y el usuario intenta abandonar la pantalla, el sistema advierte que se perderán.

La advertencia solo aparece cuando realmente existen cambios no guardados y la pérdida sería relevante. No se utiliza de forma invasiva en acciones breves. No se define un sistema general de borradores automáticos ni recuperación de sesiones de edición.

> **Ejemplo de mensaje:** “Hay cambios sin guardar. Si salís ahora, se perderán.” Acciones: “Seguir editando” y “Salir sin guardar”.

12.8 Validación

La validación se realiza con mensajes claros, cercanos al campo y expresados en lenguaje humano. Un error no debe borrar la información correcta que el usuario ya completó.

Se validan datos realmente inválidos; no se agregan restricciones artificiales para forzar un proceso innecesariamente rígido.

12.9 Feedback y prevención de duplicados

Cuando una operación tarda, el sistema informa que está procesando y evita que el usuario vuelva a ejecutarla accidentalmente.

Un botón puede pasar temporalmente a estados como Guardando… o Registrando… hasta finalizar. Después se comunica éxito o error de forma breve.

Este comportamiento es especialmente importante en pagos, ingresos, gastos, Turnos, Atenciones y análisis con IA.

12.10 Modal, panel lateral o página completa

Las confirmaciones breves y acciones muy concretas pueden resolverse en modal. Las ediciones cortas pueden utilizar un panel contextual cuando ayuda a mantener la posición de trabajo.

Las tareas sustantivas -Historia Clínica, Evaluación estructurada, construcción de rutina, revisión de Tratamiento- disponen de una página o espacio suficiente. No se colocan formularios extensos en modales pequeños ni se encadenan modales dentro de modales.

12.11 Confirmaciones

Las confirmaciones se reservan para acciones con consecuencias relevantes o difíciles de revertir: baja de Sala, eliminación definitiva, finalización de Tratamiento, cierre de una indicación o inactivación global de una Persona.

Guardar un formulario normal, cambiar un filtro o navegar no requiere confirmación.

Los mensajes explican la consecuencia en lugar de utilizar un genérico “¿Está seguro?”. Cuando existe información de impacto se muestran cantidades concretas.

12.12 Jerarquía visual de alertas

No todas las señales tienen el mismo peso. Una condición clínica “No entrenar” debe ser más visible para un Profesor que un Pago pendiente. Un sobrecupo permitido es una advertencia, no un error crítico.

La intensidad visual se utiliza de manera proporcional para que la pantalla no se convierta en una colección de alertas compitiendo entre sí.

12.13 Estados y accesibilidad

Los estados importantes nunca se comunican únicamente mediante color. Siempre se acompañan con texto o una etiqueta comprensible: Activo, Inactivo, Pago pendiente, Agendado, Atendido, No entrenar, etc.

La interfaz utiliza contraste suficiente, tamaños legibles y áreas táctiles adecuadas. La consistencia visual debe facilitar el aprendizaje del sistema.

12.14 Lenguaje

Los textos utilizan vocabulario operativo de Athleta. Los botones expresan la acción concreta: Registrar pago, Agendar turno, Registrar atención, Finalizar tratamiento o Dar de baja de Sala.

Se evita terminología técnica o etiquetas genéricas como Ejecutar proceso cuando existe un término del negocio más claro.

El mismo concepto mantiene el mismo nombre en todo el producto. Atención, Turno, Tratamiento, Alumno y Paciente no se sustituyen arbitrariamente por sinónimos en distintas pantallas.

12.15 Ayuda contextual

La ayuda se utiliza únicamente donde evita un error o explica una consecuencia importante. Los mensajes deben ser breves; idealmente una línea y, solo cuando sea necesario, dos.

No se construye un centro de ayuda complejo, tutorial permanente ni onboarding guiado para compensar interfaces difíciles. Si una pantalla requiere mucha explicación, se prioriza simplificarla.

12.16 Estados vacíos y errores

Una pantalla sin registros debe explicar claramente que todavía no existe información. Cuando un filtro no encuentra resultados, debe diferenciarse de una lista realmente vacía.

Los errores deben indicar qué puede hacer el usuario. No se muestran códigos técnicos como mensaje principal.

13. Privacidad, seguridad funcional, integridad y trazabilidad

13.1 Privacidad clínica por diseño

La privacidad clínica no depende únicamente de ocultar una sección mediante permisos. Los listados, agendas, búsquedas y dashboards muestran la mínima información necesaria para operar.

Una agenda clínica puede mostrar Paciente, hora, profesional y estado sin exponer diagnóstico o Evolución. La información clínica detallada aparece cuando un usuario autorizado entra deliberadamente a la Historia Clínica.

Este criterio reduce exposición accidental en pantallas visibles para terceros y simplifica las vistas operativas.

13.2 Separación entre operación administrativa e Historia Clínica

El Administrativo gestiona la operación clínica pero no ingresa al contenido clínico completo. Puede saber que existe una Atención, Tratamiento u Orden cuando esa referencia es necesaria para operar, sin acceder a antecedentes, Evoluciones, Evaluaciones, estudios detallados, razonamiento terapéutico o IA.

13.3 Seguridad de credenciales

Las contraseñas internas y PIN del Portal nunca se muestran después de su creación o restablecimiento inicial. Cuando se pierden, se reemplazan por credenciales temporales nuevas.

Los errores de Portal no revelan la existencia o estado de una Persona.

13.4 Protección de privilegios

El Administrativo puede gestionar usuarios estándar, pero no puede modificar cuentas con rol Administrador general ni las cuentas de Soporte Broco.

Los usuarios pueden editar sus propios datos personales, pero nunca sus propios roles ni su estado Activo/Inactivo por autoservicio.

Estas restricciones impiden que un usuario con menor privilegio pueda otorgarse capacidades superiores o apropiarse de una cuenta con mayor acceso.

13.5 Trazabilidad selectiva

Athleta Manager no incorpora un módulo general de auditoría de cada modificación. La trazabilidad se concentra donde existe valor clínico, económico o de seguridad.

En contenido clínico relevante se conserva autor/fecha y, cuando corresponde, último modificador/fecha. Las Evaluaciones físicas de Sala no incorporan trazabilidad adicional de último modificador.

En Pagos, Ingresos y Gastos se conserva quién registró el movimiento. Si fue corregido, su detalle muestra también el último modificador y la fecha de modificación, sin historial completo de valores anteriores.

Acciones sensibles como restablecimientos de contraseña o PIN, inactivación global de Personas, cambios de roles, activación/inactivación de cuentas internas y cierre de Indicaciones conservan actor y momento de la acción. Las acciones sensibles de Soporte Broco deben quedar identificadas como tales.

Las reasignaciones masivas no generan un historial específico adicional. Los análisis de IA guardados son inmutables.

13.6 Ausencia de versionado general

No se crea un historial de versiones para Rutinas, catálogos, configuración o cada campo editado. Los históricos naturales del negocio se preservan cuando existen, como Rutinas reemplazadas, Atenciones, Evoluciones, Evaluaciones, Pagos y Tratamientos finalizados.

La excepción deliberada son las Evaluaciones clínicas: conservan la definición de Protocolos y Tests con la que fueron registradas para preservar el significado clínico de sus Resultados.

13.7 Eliminación definitiva controlada

La eliminación física se utiliza únicamente donde simplifica la corrección de errores sin destruir historia relevante.

Puede aplicarse, bajo las reglas específicas definidas, a Personas creadas por error que todavía no poseen actividad ni historia relevante, Atenciones vacías, archivos clínicos cargados por error, Órdenes sin dependencias y movimientos económicos.

No se utiliza para borrar libremente Evoluciones clínicas, Evaluaciones clínicas, usuarios internos u otros registros cuya desaparición podría dejar la historia incomprensible.

13.8 Integridad de referencias históricas

Por defecto, editar un valor de catálogo significa corregir o actualizar el mismo concepto; las referencias existentes muestran su definición actual y no se conserva historial de ediciones.

Cuando un valor se retira de un catálogo, deja de estar disponible para nuevos registros sin volver incomprensible la historia que ya lo utilizó. En catálogos sin Activo/Inactivo, si Athleta necesita nuevamente un valor retirado se crea uno nuevo.

Las Evaluaciones clínicas son la excepción: preservan la definición de Protocolos y Tests utilizada al momento de registrarse.

13.9 Sin automatizaciones destructivas

La falta de pago, la inactividad clínica o el paso del tiempo no generan bajas automáticas, cierres de Tratamiento ni cancelaciones no definidas.

El sistema puede señalar situaciones para revisión, pero las decisiones con impacto relevante quedan bajo control explícito del equipo.

14. Catálogos y configuraciones funcionales

14.1 Criterio general

Los catálogos existen únicamente cuando permiten reutilizar valores de forma consistente. Se mantienen pequeños, orientados a la operación y sin estados innecesarios.

Solo Protocolos clínicos y Biblioteca Clínica utilizan Activo/Inactivo porque en ambos casos existe una necesidad real de deshabilitar temporalmente y volver a habilitar el mismo elemento. Los demás catálogos se mantienen disponibles o se retiran.

En los catálogos sin Activo/Inactivo, retirar un valor impide seleccionarlo en nuevos registros pero preserva las referencias existentes. Si en el futuro vuelve a necesitarse, se crea un nuevo valor. Editar un valor actualiza el mismo concepto y no genera versionado, salvo la preservación específica definida para Evaluaciones clínicas.

Catálogo	Contenido	Quién administra	Regla principal
Planes de Sala	Nombre, precio actual, descripción opcional	Administrativo / Administrador general	Sin Activo/Inactivo; no se retira si está asignado. Si vuelve a necesitarse tras retirarlo, se crea uno nuevo.
Medios de pago	Nombre	Administrativo / Administrador general	Sin Activo/Inactivo; retirar impide nuevos usos y preserva referencias existentes.
Categorías de gasto	Nombre	Administrativo / Administrador general	Sin Activo/Inactivo; retirar impide nuevos usos y preserva referencias existentes.
Ejercicios	Nombre, músculo principal opcional, descripción	Profesor / Administrador general	Sin Activo/Inactivo; retirar quita el ejercicio de Rutinas activas previa advertencia y preserva Rutinas históricas.
Tests físicos	Nombre, tipo, descripción opcional	Profesor / Administrador general	Sin Activo/Inactivo; Resultado abierto; retirar no altera Evaluaciones históricas.
Protocolos clínicos	Zona/tipo, secciones y tests	Kine/Osteo / Administrador general	Activo/Inactivo; pueden reactivarse.
Tests clínicos	Definición y formato de respuesta; unidad/opciones cuando corresponda	Kine/Osteo / Administrador general	Sin Activo/Inactivo; pueden retirarse; las Evaluaciones preservan la definición utilizada.
Biblioteca clínica	Título, zona/categoría, tipo, contenido/archivo, descripción	Kine/Osteo / Administrador general	Activo/Inactivo; solo fuentes activas se utilizan para IA y pueden reactivarse.
Dispositivos/Métodos	Nombre, descripción	Kine/Osteo / Administrador general	Sin Activo/Inactivo; retirar impide nuevos usos y preserva referencias históricas.
Obras sociales	Nombre	Administrativo / Administrador general	Sin Activo/Inactivo; retirada no borra asignaciones ni referencias existentes.

Cotización USD	Mes y valor 1 USD = X ARS	Administrativo / Administrador general	Una referencia editable por mes; sin historial de valores.
Contacto del Portal	Número de WhatsApp general	Administrativo / Administrador general	Configuración global; sin envíos automáticos.

14.2 Configuración de horarios de Sala

Profesor, Administrativo y Administrador general administran la grilla semanal habitual, capacidad general, capacidad específica por horario y excepciones por fecha.

Los horarios habituales se configuran por día, hora de inicio, duración y capacidad. La duración propuesta es 60 minutos y puede modificarse. Dentro del mismo día no se permiten horarios superpuestos.

La configuración se orienta a la operación real de Sala; no se crea un calendario anual complejo ni una herramienta avanzada de gestión de recursos.

14.3 Contacto general del Portal

El número de WhatsApp que se muestra en el Portal para consultas de acceso o contacto es una configuración general. Administrativo y Administrador general pueden actualizarlo. El sistema no crea configuraciones diferentes por usuario ni utiliza ese número para enviar mensajes automáticos.

14.4 Configuraciones no personalizadas por usuario

Athleta Manager no incorpora permisos por usuario, layouts personales, temas, widgets configurables o comportamientos distintos para cada integrante. La configuración se mantiene global o determinada por roles.

15. Escenarios integrales de uso

15.1 Alta de una nueva Persona desde Sala

1. Profesor, Administrativo o Administrador general inicia “Nuevo alumno”.

2. Completa Nombre, Apellido, DNI, Teléfono y Fecha de nacimiento, junto con los datos opcionales disponibles.

3. Selecciona Profesor principal y Plan, ambos obligatorios para participar de Sala.

4. El sistema verifica que el DNI no exista y crea la Persona.

5. La Persona queda incorporada a Sala, pasa a Activa y se genera automáticamente su PIN inicial del Portal.

6. El PIN se muestra una vez para que sea comunicado manualmente.

7. Desde ese momento pueden crearse Turnos fijos, reservas, Rutina, Evaluaciones físicas y Pagos.

Resultado esperado: la Persona tiene una sola ficha y una relación de Sala lista para operar, sin pasos adicionales de activación.

15.2 Alta de un nuevo Paciente sin Tratamiento

1. Kinesiólogo, Osteópata, Administrativo o Administrador general inicia “Nuevo paciente”.

2. Completa los datos generales de la Persona.

3. El sistema verifica el DNI, crea la Persona y genera su PIN inicial.

4. La Persona queda dada de alta explícitamente como Paciente y aparece inmediatamente en el listado, aunque todavía no tenga Turno, Atención ni Tratamiento.

5. Posteriormente puede agendarse un Turno, registrarse una Atención directa, iniciarse un Tratamiento o cargarse una Evaluación cuando corresponda.

No se obliga a seleccionar un profesional responsable general del Paciente.

15.3 Persona que utiliza Sala y Clínica

Caso A - Alumno que comienza a utilizar Clínica:

1. Una Alumna que ya existe en Sala necesita atención clínica.

2. El equipo busca su Nombre o DNI y abre la misma Persona.

3. Si todavía no es Paciente, ejecuta “Dar de alta como paciente”; los datos generales existentes se reutilizan y solo se completa lo necesario.

4. A partir de ahí se agenda el Turno o se registra la Atención correspondiente sin crear otra Persona.

Caso B - Paciente que comienza a utilizar Sala:

1. Un Paciente decide comenzar a entrenar.

2. Desde Sala se busca la Persona existente y se ejecuta “Incorporar a Sala”.

3. Se seleccionan Profesor principal y Plan; no se vuelve a cargar la información general ni se genera un PIN nuevo.

4. La Persona queda simultáneamente como Alumno y Paciente sobre la misma ficha.

En ambos casos el Portal utiliza el mismo DNI/PIN y los permisos internos continúan separando correctamente la información de Sala y la Historia Clínica.

15.4 Consulta clínica aislada sin Tratamiento

1. Una Persona ya dada de alta como Paciente consulta por una situación puntual y es atendida sin Turno previo.

2. Desde su ficha, el profesional elige Registrar atención.

3. El sistema propone fecha/hora actual y profesional autenticado cuando corresponde; la fecha puede ajustarse si se está cargando una consulta pasada.

4. El profesional puede escribir una Evolución y finalizar la carga sin crear un Tratamiento.

5. La Atención actualiza Última atención.

6. Si la Persona no participa de Sala, no tiene Turnos clínicos futuros Agendados ni Tratamientos En curso, no queda Activa de forma permanente únicamente por esa Atención histórica.

15.5 Turno clínico de una Persona Inactiva

1. Una Paciente histórica Inactiva solicita una nueva consulta.

2. Administrativo o profesional clínico agenda un Turno futuro.

3. Mientras el Turno permanezca futuro y Agendado, la Persona pasa automáticamente a Activa.

4. El Portal queda habilitado y muestra el Turno.

5. Si el Turno se cancela, o si llega su hora de inicio sin existir otra actividad vigente, el estado general se recalcula y la Persona puede volver a Inactiva.

15.6 Turno marcado Atendido sin Evolución

1. El Administrativo marca como Atendido un Turno clínico.
2. El sistema crea automáticamente la Atención con Paciente, fecha/hora y profesional del Turno.
3. Como el Administrativo no registra contenido clínico, confirma la Atención sin Evolución.
4. El sistema muestra una advertencia breve, pero no bloquea.
5. Un profesional clínico puede agregar posteriormente la Evolución a esa Atención.

15.7 Tratamiento con más de un profesional

1. Un Kinesiólogo crea un Tratamiento y queda propuesto como responsable.
2. En una consulta posterior interviene una Osteópata.
3. La Osteópata registra la Atención y su Evolución con su propia autoría.
4. El Tratamiento continúa teniendo al Kinesiólogo como responsable hasta que alguien lo cambie explícitamente.

La responsabilidad organiza el caso, pero no impide que otro profesional consulte o intervenga.

15.8 Tratamiento sin Atención durante 30 días

1. Un Tratamiento continúa En curso y se cumplen 30 días completos sin una nueva Atención.

2. Aparece dentro de la referencia Tratamientos sin Atención reciente del Inicio de Clínica.

3. El profesional abre el listado filtrado y revisa el caso.

4. Puede mantenerlo En curso o finalizarlo, por ejemplo por Interrupción.

El sistema no toma esa decisión automáticamente.

15.9 Finalización de Tratamiento con restricción de Sala

1. Un Tratamiento se encuentra En curso y tiene una indicación activa “Con restricciones” para Sala.
2. El profesional decide finalizar el Tratamiento por Alta.
3. El sistema informa que existe una indicación de Sala activa y recomienda revisarla.
4. La finalización puede continuar.
5. La indicación se mantiene activa hasta que alguien la cierre o hasta que la Persona deje Sala.

15.10 Baja de Sala manteniendo actividad Clínica

1. Una Persona participa de Sala y tiene un Tratamiento clínico En curso.
2. Se ejecuta Dar de baja de Sala.
3. Se terminan turnos fijos, se cancelan reservas futuras, la rutina activa pasa a histórica y se cierran las indicaciones activas de Sala.
4. Se eliminan las asignaciones actuales de Profesor principal y Plan.
5. El Tratamiento clínico continúa sin cambios.
6. La Persona continúa Activa por su Tratamiento.

15.11 Reingreso a Sala

1. Una Persona que dejó Sala vuelve meses más tarde.
2. Se abre su ficha histórica y se selecciona Incorporar a Sala.
3. Se eligen Profesor principal y Plan nuevamente.
4. No se restauran turnos fijos, rutina ni indicaciones clínicas antiguas.
5. El mes de reingreso comienza su situación de pago actual. Los meses sin participación no aparecen como deuda. Si la baja y el reingreso ocurren dentro del mismo mes y ya existe un Pago válido para ese Mes/Año, ese pago continúa siendo válido y no se registra un segundo pago obligatorio.

15.12 Cambio permanente de un horario con turnos y reservas futuras

1. Athleta decide cambiar de forma permanente el día o la hora de inicio de un horario semanal, o eliminarlo, desde una fecha futura.

2. El sistema considera que el horario anterior fue reemplazado e identifica los Turnos fijos y reservas puntuales futuras afectados.

3. Antes de confirmar muestra cuántas Personas serán afectadas.

4. Al confirmar, los Turnos fijos terminan desde la fecha indicada y las reservas futuras correspondientes se cancelan.

5. El sistema no reasigna automáticamente a los Alumnos.

Cambiar únicamente capacidad o duración mantiene el mismo horario y no cancela asignaciones existentes.

15.13 Cierre excepcional de un horario por una fecha

1. Un horario habitual debe cerrarse únicamente por un feriado o situación puntual.
2. Se registra una excepción para esa fecha.
3. Si existen reservas, el sistema muestra las personas afectadas.
4. Al confirmar, se cancela esa ocurrencia.
5. Los turnos fijos continúan normalmente la semana siguiente.

15.14 Reducción de capacidad con reservas existentes

1. Un horario tiene 10 reservas y su capacidad se reduce excepcionalmente a 8.
2. El sistema informa que la cantidad reservada supera la nueva capacidad.
3. Las 10 reservas se conservan.
4. El Portal muestra Sin lugar para nuevas reservas.
5. Un usuario interno todavía puede agregar una persona con advertencia de sobrecupo si la operación lo requiere.

15.15 Pago de Sala con importe diferente al Plan

1. El Plan actual propone un importe determinado.
2. Por una situación acordada, Athleta cobra un valor diferente.
3. Profesor, Administrativo o Administrador general modifica el importe.

4. El sistema solicita Motivo de ajuste.
5. El pago queda registrado para ese mes con el importe real, sin alterar el precio del Plan.

Ejemplo complementario: si el pago corresponde a agosto pero se cobra el 05/09, agosto queda como Pago registrado para el Alumno, mientras que el movimiento financiero pertenece a septiembre.

15.16 Pago duplicado cargado por error

1. Un pago del mismo mes fue cargado por error o se detecta un movimiento duplicado.
2. Un usuario con permiso abre el movimiento y elige Eliminar.
3. El sistema confirma claramente cuál es el pago que se eliminará.
4. El registro se elimina definitivamente y los totales se recalculan.
5. Si ya no queda un pago válido para el mes actual, el Alumno vuelve a figurar como Pago pendiente.

15.17 Gasto cargado por un Profesor

1. Un Profesor realiza una compra operativa para Athleta.
2. Desde una acción rápida registra Fecha, Importe, Categoría, Medio de pago, Área y descripción opcional.
3. El sistema confirma la carga.
4. El Profesor no necesita acceso al listado general de Gastos para poder registrar el movimiento.
5. Administrativo y Administrador general pueden revisar, corregir o eliminar el gasto posteriormente.

15.18 Cobro de Obra social posterior a la Atención

1. Una Atención se realiza en agosto.
2. La Obra social paga a Athleta en septiembre.
3. El ingreso se registra con Fecha de cobro de septiembre, Pagador Obra social y el Medio de pago correspondiente.
4. Puede vincularse a la Atención y a una Orden del Paciente si esas referencias aportan contexto.
5. Los totales financieros consideran el ingreso en septiembre, cuando el dinero fue efectivamente recibido.

15.19 Orden vencida

1. Una Orden de obra social tiene Fecha de vencimiento ya pasada.
2. La historia continúa mostrando la Orden y puede señalar que está vencida.
3. La Orden no bloquea Turnos, Atenciones ni Ingresos.
4. El equipo decide operativamente si necesita una nueva Orden.

15.20 Evaluación clínica analizada con IA y luego corregida

1. El profesional completa una Evaluación y ejecuta Analizar evaluación con Inteligencia Artificial.
2. Revisa el resultado y lo guarda.
3. Más tarde detecta que un resultado de test estaba mal cargado y corrige la Evaluación.
4. El análisis ya guardado permanece intacto como resultado histórico.
5. Si necesita una nueva lectura, ejecuta otro análisis sobre los datos corregidos y puede guardarlo como un resultado independiente.

15.21 Inactivación o retiro del rol Profesor con alumnos asignados

1. Administrativo o Administrador general intenta inactivar una cuenta de Profesor o quitarle el rol Profesor.
2. El sistema detecta Alumnos que todavía lo tienen como Profesor principal.
3. La acción queda bloqueada y muestra cantidad/listado de Alumnos pendientes.
4. El usuario realiza una reasignación masiva a otro Profesor.
5. Rutinas, Evaluaciones físicas y demás registros previos permanecen asociados a sus autores originales; solo cambia la responsabilidad actual de Profesor principal.

6. Una vez resueltas las responsabilidades, la cuenta puede quedar Inactiva o perder el rol Profesor.

15.22 Inactivación o retiro del último rol clínico

1. Se intenta inactivar a un Kinesiólogo u Osteópata, o quitarle su último rol clínico, mientras mantiene Tratamientos En curso y/o Turnos futuros Agendados.
2. El sistema muestra las responsabilidades pendientes y no permite completar todavía la inactivación ni el retiro del último rol clínico.
3. Se reasignan Tratamientos y Turnos futuros Agendados a profesionales elegidos por el equipo.
4. La Historia Clínica previa conserva sus autores originales.
5. Luego la cuenta puede inactivarse o perder el último rol clínico, según corresponda. Si conserva otro rol clínico -por ejemplo, se quita Kinesiólogo pero mantiene Osteópata-, esta protección no bloquea la acción.

15.23 Usuario interno que necesita atención clínica

1. Una persona que trabaja en Athleta como Administrativo necesita una consulta de Osteopatía.

2. Su cuenta interna continúa existiendo en Equipo con email y contraseña.

3. Se crea o utiliza su ficha de Persona con DNI y PIN y, si todavía no es Paciente, se realiza el alta explícita en Clínica.

4. La Atención y la Historia Clínica se registran sobre la Persona, no sobre la cuenta del Equipo.

5. Las reglas de privacidad clínica se aplican normalmente.

15.24 Inactivación global de una Persona con actividad en ambas áreas

1. Administrativo o Administrador general abre la ficha y selecciona Inactivar persona.

2. El sistema identifica Turnos fijos, reservas futuras de Sala, Tratamientos En curso y Turnos clínicos futuros Agendados.

3. La confirmación resume el impacto.

4. Al confirmar, la acción tiene efecto desde ese momento: se ejecutan las bajas y cancelaciones futuras definidas y los Tratamientos se finalizan por Interrupción.

5. Actividades cuya hora de inicio ya ocurrió permanecen intactas y pueden corregirse posteriormente según sus reglas normales.

6. La Persona queda Inactiva, sin acceso al Portal, y toda la historia queda disponible para consulta autorizada.

16. Límites funcionales y exclusiones

16.1 Principio

Los siguientes límites forman parte de la definición del sistema y evitan introducir complejidad que Athleta no necesita para su operación actual:

- No existen roles personalizados ni permisos especiales por usuario; se utilizan roles combinables definidos.
- No existe rol Dueño separado del Administrador general.
- No existe pausa o congelamiento de participación en Sala; una Persona participa o no participa.
- La falta de pago no bloquea asistencia, reservas, Portal ni produce bajas automáticas.
- No existe balance de recuperos, créditos de clases ni relación entre una ausencia y una reserva puntual.
- Los Planes no limitan asistencia ni cantidad de reservas, y no existe control automático de frecuencia semanal.
- Las reservas pasadas y los Turnos clínicos pasados no cambian automáticamente a Ausente; los estados se corrigen manualmente.
- No existe cierre diario obligatorio de asistencia.
- Los Turnos fijos no reconstruyen ocurrencias retroactivas.
- El Alumno no registra cargas reales, ejercicios completados, comentarios ni seguimiento de sesión desde el Portal.
- Las Evaluaciones físicas de Sala utilizan Resultados abiertos; no calculan 1RM, puntajes ni conversiones automáticas.
- No existe historial de pagos ni cuenta corriente visible en el Portal.
- El Paciente no puede autoagendar Turnos clínicos.
- Clínica no utiliza una grilla de disponibilidad por profesional ni cupos publicados para auto-reserva.
- Los Turnos clínicos no se asocian a Tratamientos.
- Los Tratamientos no se cierran automáticamente por falta de Atenciones.
- No existe obligación de crear Tratamiento para una consulta aislada ni de crear Turno retrospectivo para una Atención espontánea.
- No existe una Evaluación clínica estructurada obligatoria en cada Atención.
- No existe cola permanente de Atenciones sin Evolución.
- No existe versionado completo ni auditoría general de cada cambio del sistema.
- La IA no navega Internet, no actúa automáticamente y no sustituye la decisión profesional.
- No existen porcentajes de certeza diagnóstica generados por la IA.
- No existe módulo separado de mediciones; los valores objetivos forman parte de los Tests clínicos.
- No se incorporan videos de Pacientes como adjuntos clínicos en el alcance definido.
- No existe tarifario clínico ni cálculo automático de honorarios o prestaciones.
- Las Órdenes de obra social no consumen sesiones, no liquidan prestaciones y no bloquean por vencimiento.
- No existe facturación electrónica, conciliación con Obras sociales, copagos estructurados ni cuentas corrientes de financiadores.
- No existe lógica de devoluciones o reversiones económicas; los movimientos cargados por error se corrigen o eliminan según sus permisos.
- Athleta Manager no procesa pagos online.
- No existen recordatorios automáticos por WhatsApp, email o SMS.
- No existe exportación genérica de Personas, Alumnos o Pacientes desde los listados de uso diario.
- No existe constructor de reportes ni reportes PDF configurables.
- No existe dashboard financiero avanzado con presupuestos, proyecciones o conciliaciones bancarias.
- No existen cuentas de padres/tutores ni flujo especial para menores.
- No existe módulo de consentimientos, firmas o formularios legales.
- No existe aplicación móvil separada; el producto es una aplicación web responsive.
- No existe personalización de widgets, menús, colores o layouts por usuario.

16.2 Funciones que pueden evolucionar más adelante

La estructura del sistema permite que en el futuro aparezcan necesidades adicionales, pero ninguna se anticipa mediante estados o circuitos sin uso actual. Si Athleta requiere facturación más compleja, integraciones, controles de obra social, notificaciones o seguimiento avanzado de entrenamiento, esas capacidades deberán definirse a partir de una necesidad concreta antes de incorporarse.

17. Glosario funcional

Término	Definición
Activo	Estado general de una Persona que participa de Sala, tiene un Tratamiento En curso o posee un Turno clínico futuro Agendado.
Administrativo	Rol operativo transversal que gestiona personas, Sala, agenda clínica, economía y usuarios estándar, sin acceso a Historia Clínica completa.
Administrador general	Rol con acceso funcional completo a Athleta Manager y gestión de cuentas de Athleta de mayor privilegio.
Alumno	Persona incorporada actualmente a Sala, con Profesor principal y Plan.
Atención	Registro de una consulta clínica efectivamente realizada; puede asociarse opcionalmente a un único Tratamiento.
Biblioteca Clínica	Conjunto de fuentes aprobadas por Athleta para consulta profesional y análisis con IA.
Condición de entrenamiento	Estado de una indicación clínica para Sala: Sin restricciones, Con restricciones o No entrenar.
Evolución	Documentación clínica narrativa asociada a una Atención.
Evaluación clínica	Registro estructurado de tests y hallazgos asociado a una Atención.
Evaluación física	Evaluación de rendimiento de Sala basada en Tests con Resultados abiertos, separada de la Historia Clínica.
Gasto	Egreso económico registrado para Sala, Clínica o uso General.
Inactivo	Estado general de una Persona sin actividad vigente y sin acceso al Portal.
Indicación para Sala	Información clínica expresamente destinada a condicionar o guiar el entrenamiento.
Ingreso clínico	Dinero efectivamente recibido por Athleta relacionado con un Paciente.
Pago de Sala	Pago mensual registrado para un Alumno que participa de Sala.
Paciente	Persona dada de alta explícitamente en Clínica, condición que se conserva aunque luego no tenga actividad clínica vigente.
Persona	Identidad única transversal del individuo dentro de Athleta Manager.
Plan	Referencia comercial de Sala con nombre y precio actual, sin control automático de frecuencia.
Profesor principal	Profesor asignado como referencia principal de un Alumno mientras participa de Sala.
Protocolo clínico	Plantilla reutilizable de secciones y tests para guiar una Evaluación clínica.

Término	Definición
Reserva puntual	Reserva de Sala para una fecha concreta, sin relación con recuperos o créditos.
Rutina activa	Única rutina vigente visible en el Portal del Alumno.
Soporte Broco	Rol excepcional administrado por Broco Solutions para resolución de incidentes.
Tratamiento clínico	Proceso de seguimiento clínico opcional, con Profesional responsable y estado En curso/Finalizado; puede agrupar múltiples Atenciones.
Turno clínico	Consulta planificada en la agenda Clínica, con fecha/hora, duración y profesional; no se asocia a Tratamientos.
Turno fijo	Asignación semanal habitual de Sala para un Alumno, con Fecha de inicio y Fecha de finalización opcional.

Fin de la Descripción Integral del Sistema Athleta Manager